PFE - Pleito de Financiamento Externo
Programa de Fortalecimento do SUS no Estado do Piauí

Proponente: Estado do Piauí
Processo SEI: 03101.001016/2025-56
Código do pleito: 4713068623/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 04
1. 2. 4. Resultados 06
1. 3. Objetivo 09
1. 4. Indicadores 11
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 11
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 12
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 14
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 15
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 17
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 18
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 20
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 21
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 22
1. 5. Componentes 24
1. 5. 1. Informações do 1° componente 24
1. 5. 2. Informações do 2° componente 26
1. 5. 3. Informações do 3° componente 29
1. 5. 4. Informações do 4° componente 31
1. 6. Beneficiários 33
1. 7. Anexos 35
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 36
2. 1. Áreas estratégicas 36
2. 2. Anexos 38
3. GESTÃO 39
3. 1. Arranjo institucional 39
3. 1. 1. Descrição 39
3. 1. 2. Orgãos Executores 40
3. 1. 3. Estrutura Operacional 40
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 41
3. 2. Operacionalização e Manutenção 41
3. 3. Planejamento Estratégico 42
3. 4. Anexos 43
4. RISCOS 44
4. 1. Informações do 1° risco 44
4. 2. Informações do 2° risco 46
4. 3. Informações do 3° risco 48
4. 4. Informações do 4° risco 50
4. 5. Informações do 5° risco 53
4. 6. Anexos 55
5. FINANCIAMENTO 56
5. 1. Condições Financeiras da Operação 56
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 56
5. 2. Cronograma de Desembolso 59
5. 3. Contragarantias 60

5. 4. Anexos 60
6. ETAPAS REALIZADAS 61
6. 1. Etapas realizadas 61
6. 2. Anexos 61
7. CONTATOS 62
7. 1. Contatos 62
7. 2. Anexos 62
8. Baixar todos os anexos 63

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: Programa de Fortalecimento do SUS no Estado do Piauí
Sigla: PROSUS PI
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Proponente: Estado do Piauí

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O Estado do Piauí, situado na região Nordeste do Brasil, ocupa uma vasta área de aproximadamente 251.529 km², dividida em 224 municípios. De acordo com estimativas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024), abriga cerca de 3,37 milhões de habitantes, tornando-se o terceiro maior estado da região em extensão territorial, atrás apenas da Bahia e do Maranhão. Apesar de os últimos anos terem registrado alguns avanços socioeconômicos, o Piauí ainda apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,69, abaixo da média nacional (0,760), posicionando-se em 23º lugar entre as 27 unidades federativas (PNUD, 2024).

Do ponto de vista social, a realidade local evidencia altos níveis de desigualdade e vulnerabilidade. Dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS, 2024) apontam que 55% dos piauienses (cerca de 1,8 milhão de pessoas) vivem em situação de pobreza ou baixa renda, enquanto 1,4 milhão são beneficiários do Programa Bolsa Família. Nesse contexto, a alta dependência de programas públicos de assistência reflete a insuficiência de oportunidades de inserção socioeconômica. Esse cenário socioeconômico frágil repercute diretamente na demanda por serviços públicos, especialmente em saúde, educação e assistência social.

O Estado vivencia também uma intensa transição demográfica, marcada pela redução das taxas de fecundidade e pelo crescimento acelerado da população idosa. A proporção de pessoas com 60 anos ou mais passou de 8,6% em 2000 para 15,3% em 2022. Esse processo acarreta mudanças substanciais na estrutura familiar e no perfil epidemiológico, elevando a prevalência de Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNTs) e gerando maior demanda por cuidados continuados e serviços de saúde especializados. Em paralelo, convivem ainda importantes desafios relacionados às doenças infectocontagiosas, demonstrando que o Piauí se depara com o fenômeno da tripla carga de doenças.

Em termos político-institucionais, o Piauí tem buscado fortalecer a governança e as capacidades estatais para enfrentar essas vulnerabilidades de forma regionalizada. O Plano Plurianual (PPA) 2024-2027 reflete esse compromisso, ao elencar como objetivos estratégicos o combate à pobreza, a promoção do desenvolvimento regional, a ampliação do acesso a serviços de qualidade e o fortalecimento da saúde pública, em consonância com o Objetivo Estratégico nº 102 do PPA ("Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)"). O Estado conta, ainda, com o Plano Estadual de Saúde (PES) 2024-2027, construído de forma participativa, que prioriza a regionalização dos serviços e a organização e fortalecimento da Redes de Atenção à Saúde, amparado em instrumentos como o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e o Planejamento Regional Integrado (PRI).

Do ponto de vista territorial, a organização do sistema de saúde abrange quatro macrorregiões e doze regiões de saúde, concebidas para otimizar a oferta e a gestão de ações e serviços de saúde, levando em conta as especificidades sociais, demográficas e geográficas de cada território. Entretanto, persistem disparidades no acesso e na qualidade da atenção, em especial na média e alta complexidade, nas diferentes regiões do estado. A necessidade de infraestruturas mais robustas e de processos de gestão mais eficientes é evidenciada pelas filas de espera para procedimentos, pela carência de leitos hospitalares em algumas localidades e pela limitação de recursos técnicos e humanos.

Somam-se a esses fatores a ampliação da urbanização, que concentra 65,8% da população em áreas urbanas, o predomínio de população negra (64,83% pardos e 12,25% negros) e a prevalência de grupos em situação de vulnerabilidade socioeconômica e de saúde. Nesse contexto, a agenda de fortalecimento do SUS torna-se premente para promover maior inclusão e equidade, reduzindo as desigualdades territoriais e garantindo o direito constitucional à saúde.

Assim, ao considerar todo esse arcabouço de desafios socioeconômicos, demográficos e político-institucionais, evidencia-se a relevância do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI). O Programa se insere numa conjuntura em que a modernização e a expansão das redes de saúde, aliadas à otimização das capacidades administrativas do estado, são fundamentais para combater a pobreza, reduzir desigualdades e melhorar a qualidade de vida da população piauiense. A concretização desses objetivos alinha-se aos compromissos previstos no PPA 2024-2027 e aos princípios do Plano Estadual de Saúde 2024-2027, reforçando o dever do Poder Público de prover serviços de saúde eficientes, acessíveis e de qualidade a todos os cidadãos do Estado.

1. 2. 2. **Problema:**

Os principais problemas e necessidades que o PROSUS PI visa enfrentar podem ser agrupados em cinco grandes eixos, detalhados a seguir:

1. 2. 2. 1.

Vazios assistenciais em atenção especializada ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade

- 1. 2. 2. 2.

  Causas: O Piauí conta com apenas alguns polos regionais de alta complexidade, concentrados principalmente na capital e em algumas cidades de maior porte, como por exemplo: Parnaíba, Picos e Floriano como sede de Macrorregiões de Saúde. Em diversas regiões, há escassez de unidades especializadas e de profissionais treinados para atendimento em áreas como cardiologia, oncologia e ortopedia. O baixo nível de investimento e a rede fragmentada dificultam a criação e expansão da oferta de serviços, resultando em demora nos diagnósticos e tratamentos.

- 1. 2. 2. 3.

  Consequências: A população das regiões do sul do estado, em especial, das macrorregiões semiárido e cerrados com vazios assistenciais periféricas e do interior precisa se deslocar por longas distâncias ou enfrentar filas de espera prolongadas para consultas e cirurgias, que podem chegar a 464 dias (SESAPI, 2022). Isso agrava riscos de complicações clínicas e cirúrgicas, eleva as taxas de morbimortalidade e acentua desigualdades regionais.

1. 2. 2. 4.

Infraestrutura hospitalar inadequada

- 1. 2. 2. 5.

  Causas: Diversas unidades hospitalares foram criadas sem planejamento contínuo de manutenção e atualização tecnológica. Soma-se a isso a limitação de recursos públicos, que impacta investimentos em reformas, ampliação de leitos e aquisição de equipamentos.

- 1. 2. 2. 6.

  Consequências: O número de leitos disponíveis é insuficiente em muitas cidades, comprometendo a capacidade de internação, sobretudo para casos mais complexos. As instalações precárias põem em risco a segurança dos pacientes e dos profissionais, resultando em maior rotatividade de profissionais de saúde e menor resolutividade dos serviços.

1. 2. 2. 7.

Fragilidade na atenção a grupos vulneráveis

- 1. 2. 2. 8.

  Causas: Faltam políticas e serviços especializados que atendam às necessidades específicas de idosos, pessoas com deficiência, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras populações em maior vulnerabilidade socioeconômica. A ausência de centros de referência e a escassez de profissionais capacitados elevam a dependência de grandes centros urbanos.

- 1. 2. 2. 9.

  Consequências: A carência de cuidados adequados eleva a taxa de complicações médicas para esses grupos, além de dificultar a inserção social e o exercício pleno de direitos. Em muitos casos, a falta de atendimento multiprofissional adequado agrava quadros clínicos que poderiam ser gerenciados e tratados precocemente.

1. 2. 2. 10.

Falta de integração e modernização dos processos de gestão

- 1. 2. 2. 11.

Causas: As tecnologias de gestão em saúde, como prontuários eletrônicos e sistemas de regulação de leitos, não estão plenamente consolidadas ou integradas em todo o estado. Além disso, há dificuldades de governança e coordenação entre os diferentes níveis de atenção, reforçando a fragmentação e fragilidade no acesso.

- 1. 2. 2. 12.

  Consequências: Ocorre desperdício de recursos, demora na regulação de procedimentos, duplicação de exames e dificuldades no encaminhamento adequado dos pacientes ao serviço especializado correspondente. Falhas no monitoramento e na avaliação de processos também impactam a qualidade e a transparência na prestação de contas à sociedade.

1. 2. 2. 13.

Escassez de linhas de cuidado e protocolos clínicos bem estabelecidos

- 1. 2. 2. 14.

  Causas: Falta de definição clara de fluxos assistenciais regionais, bem como lacunas no planejamento e na capacitação continuada das equipes para o manejo adequado das principais doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, neoplasias) e a saúde materno-infantil. A transição demográfica e a diversidade epidemiológica demandam organização e protocolos baseados em evidências.

- 1. 2. 2. 15.

  Consequências: A baixa integração entre os serviços faz com que pacientes crônicos, gestantes de alto risco ou pessoas com condições agudas fiquem sem seguimento regular ou coordenação do cuidado pela APS. Esse quadro leva à progressão das doenças, aumentando as taxas de hospitalização e mortalidade por causas evitáveis.

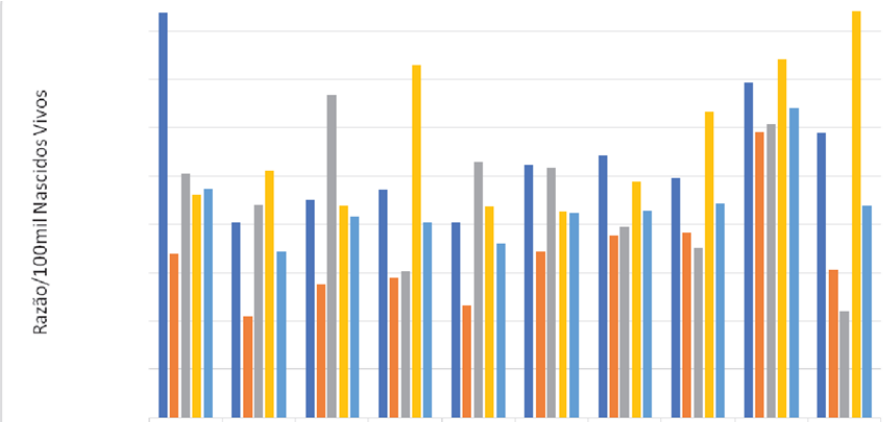
Como resultado, a situação inicial reflete um sistema de saúde que, embora universal, apresenta significativos problemas de acesso e qualidade, sobretudo em média e alta complexidade. A consequência imediata é o agravamento de indicadores como a Razão de Mortalidade Materna (87,7 em 2022, acima da média nacional de 53,5 e do patamar de 30 estabelecido pelos ODS), bem como taxas elevadas de mortalidade infantil (18,6 por mil nascidos vivos, superando a média nacional de 13,31) (SESAPI, 2024).

Gráfico 1 - Mortalidade na Infância (menores de 5 anos) por mil nascidos vivos nas Macrorregiões de Saúde do Piauí – 2013 a 2022.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Semi-arido	20,1	19,9	19,7	20,3	18,2	19,7	15,2	16,9	17,9	20,2
Meio Norte	18,3	16,9	16,4	16,6	18,3	16,7	16,1	15,0	15,3	18,6
Litroral	20,4	17,4	19,7	18,1	15,9	16,2	18,9	14,9	15,4	17,8
Cerrados	18,2	18,6	13,1	22,5	18,6	17,9	17,1	18,7	14,6	18,2
Piauí	19,0	17,8	17,0	18,6	17,8	17,3	16,8	16,0	15,6	18,6

Gráfico 2 – Razão da Mortalidade Materna no Piauí, por macrorregião de saúde- 2013-2022.



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Semi-arido	167,4	80,8	90,2	94,3	80,9	104,5	108,5	99,3	138,5	117,7
Meio Norte	67,7	41,8	54,9	57,9	46,4	68,8	75,4	76,7	118,2	61,3
Litoral	101,0	88,3	133,4	60,3	105,9	103,5	79,1	70,4	121,6	43,8
Cerrados	92,2	102,3	87,6	146,1	87,2	85,2	97,5	126,8	148,5	168,4
Total	94,8	68,8	83,2	80,9	72,1	84,9	85,5	88,4	128,3	87,7

1. 2. 3. **Solução:**

Com base no diagnóstico situacional e nos problemas identificados no Piauí, o PROSUS PI delineou um conjunto abrangente de ações que visam a modernizar, ampliar e integrar os serviços de saúde em todas as Macrorregiões de Saúde do Estado. As soluções estão estreitamente alinhadas aos objetivos do Plano Estadual de Saúde (PES 2024-2027) e do PPA 2024-2027. A seguir, detalham-se as principais iniciativas e como elas se relacionam com os problemas e necessidades já mapeados:

1. 2. 3. 1.

Expansão e fortalecimento da oferta de atenção especializada ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade

- **1. 2. 3. 2.**

  Descrição Detalhada:

  - 1. 2. 3. 3.

    Criação, reforma e/ou ampliação de unidades de saúde, como policlínicas e hospitais regionais, para disponibilizar consultas especializadas, exames diagnósticos de maior complexidade e cirurgias eletivas.

  - 1. 2. 3. 4.

    Implementação de uma rede de policlínicas voltadas a especialidades médicas e exames de maior complexidade, conectadas às unidades de Atenção Primária à Saúde para garantir a referência e contrarreferência adequadas. Em paralelo, serão realizados mutirões de cirurgias, sobretudo em áreas onde há maior tempo em fila de espera.

- 1. 2. 3. 5.

  Problema Atendido:

  - 1. 2. 3. 6.

    Diminui os vazios assistenciais em média e alta complexidade, reduzindo o tempo de espera para procedimentos especializados e a necessidade de deslocamentos onerosos. Também propicia maior equidade regional e agiliza diagnósticos, aumentando a resolutividade clínica.

1. 2. 3. 7.

Modernização da infraestrutura hospitalar

- **1. 2. 3. 8.**

  Descrição Detalhada:

  - 1. 2. 3. 9.

    Investimentos em obras de reforma ou requalificação em cerca de dez hospitais regionais, priorizando a segurança estrutural, a acessibilidade e o conforto dos pacientes.

  - 1. 2. 3. 10.

    Adoção de práticas sustentáveis nos projetos de engenharia, incluindo sistemas de captação e reuso de água, painéis solares fotovoltaicos e processos de certificação (LEED), reduzindo custos operacionais a longo prazo.

- 1. 2. 3. 11.

  Problema Atendido:

  - 1. 2. 3. 12.

    Superar a precariedade das instalações e a escassez de leitos, ampliando a capacidade de internação. Garantir ambientes melhor equipados e adequados às normas de segurança do paciente, o que contribui para a redução de riscos hospitalares e aumenta a satisfação de usuários e profissionais.

1. 2. 3. 13.

Implantação de serviços específicos para grupos vulneráveis

- **1. 2. 3. 14.**

  Descrição Detalhada:

  - 1. 2. 3. 15.

    Criação de centros de referência e reabilitação para pessoas idosas, com deficiência ou necessidades especiais (incluindo Transtorno do Espectro Autista - TEA). Essas unidades terão equipes multidisciplinares para atendimento humanizado e integrado.

  - 1. 2. 3. 16.

    Integração desses centros às Redes de Atenção à Saúde (RAS), garantindo fluxo contínuo de pacientes entre Atenção Primária, atenção especializada ambulatorial e hospitalar, incluindo o acompanhamento domiciliar quando necessário.

- 1. 2. 3. 17.

  Problema Atendido:

  - 1. 2. 3. 18.

    Responde à carência de serviços para populações que exigem cuidados diferenciados, assegurando maior equidade no acesso e evitando que essa parcela da população fique desassistida ou se desloque para outras regiões. Também reduz as complicações clínicas associadas à falta de acompanhamento regular.

1. 2. 3. 19.

Integração e modernização da gestão em saúde

- **1. 2. 3. 20.**

  Descrição Detalhada:

  - 1. 2. 3. 21.

Implementação de sistemas de informação interoperáveis em toda a rede, incluindo prontuários eletrônicos, plataformas de telemedicina e centrais de regulação. A construção de uma central de armazenamento e controle de insumos e medicamentos otimizará a logística e minimizará perdas e desabastecimentos.

- 1. 2. 3. 22.

  Desenvolvimento de protocolos claros de referência e contrarreferência, associado ao monitoramento de indicadores-chave. Capacitação de equipes gestoras em ferramentas de planejamento e gestão de custos, bem como em técnicas de monitoramento e avaliação contínua dos serviços.

- 1. 2. 3. 23.

  Problema Atendido:

  - 1. 2. 3. 24.

    Ataca as ineficiências administrativas, a dificuldade de coordenação entre serviços e a baixa transparência no uso dos recursos públicos. Ao aumentar a capacidade de regulação, agiliza a alocação de leitos e outros recursos, reduzindo filas e melhorando o gerenciamento financeiro.

1. 2. 3. 25.

Estruturação de linhas de cuidado e protocolos clínicos

- **1. 2. 3. 26.**

  Descrição Detalhada:

  - 1. 2. 3. 27.

    Criação de protocolos clínicos unificados para as principais condições crônicas (hipertensão, diabetes, doenças cardiovasculares, doenças renais, neoplasias) e para a saúde materno-infantil, respeitando as especificidades de cada macrorregião de saúde. Esses protocolos incluirão etapas de promoção e prevenção, diagnóstico precoce, acompanhamento ambulatorial, terapias especializadas e atenção domiciliar.

  - 1. 2. 3. 28.

    Oferta de treinamentos e educação continuada para as equipes de saúde (médicos, enfermeiros, agentes comunitários).

- 1. 2. 3. 29.

  Problema Atendido:

  - 1. 2. 3. 30.

    Garante a continuidade do cuidado e a homogeneidade na abordagem clínica, evitando que os pacientes enfrentam lacunas no tratamento. Favorece ainda a melhoria dos indicadores de morbimortalidade, sobretudo em doenças crônicas e na saúde de mulheres e crianças.

1. 2. 4. **Resultado:**

A implementação do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) projeta benefícios diretos e externalidades positivas que se somam às iniciativas propostas no Plano Estadual de Saúde (PES 2024-2027) e aos Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027 (nº 102, 111, 202 e 303). Em cada eixo de ação, a superação dos problemas descritos trará avanços relevantes para a população, para o sistema de saúde e para o desenvolvimento regional.

1. 2. 4. 1.

Melhoria do acesso à atenção especializada ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade

- **1. 2. 4. 2.**

  Benefícios diretos:

  - 1. 2. 4. 3.

    Diminuição do tempo de espera para procedimentos especializados, favorecendo diagnósticos precoces e intervenções oportunas.

  - 1. 2. 4. 4.

    Promoção de maior equidade entre as regiões, ao ofertar serviços especializados próximo ao local de residência dos usuários.

- 1. 2. 4. 5.

  Externalidades positivas:

  - 1. 2. 4. 6.

    Geração de empregos e movimentação econômica local, pois a instalação ou ampliação de serviços pode demandar fornecedores, mão de obra e insumos.

  - 1. 2. 4. 7.

    Crescente percepção de confiabilidade e eficiência do SUS, fortalecendo o vínculo entre população e rede pública de saúde.

1. 2. 4. 8.

Requalificação da infraestrutura hospitalar

- **1. 2. 4. 9.**

  Benefícios diretos:

  - 1. 2. 4. 10.

    Ambientes físicos seguros, adequados e humanizados para pacientes e profissionais, reduzindo riscos de infecção e melhorando a experiência de atendimento.

  - 1. 2. 4. 11.

    Ampliação de leitos gerais e especializados, mitigando a superlotação em períodos de maior demanda e facilitando o atendimento de casos de maior gravidade.

- 1. 2. 4. 12.

  Externalidades positivas:

  - 1. 2. 4. 13.

    Maior atratividade das unidades de saúde para profissionais especializados, que tendem a se fixar em locais com melhores condições de trabalho.

  - 1. 2. 4. 14.

    Economia futura em reparos e manutenção, já que a modernização estrutural reduz a necessidade de intervenções emergenciais.

1. 2. 4. 15.

Ampliação de serviços voltados a grupos vulneráveis

- **1. 2. 4. 16.**

  Benefícios diretos:

- 1. 2. 4. 17.

  Inclusão de idosos, pessoas com deficiência e indivíduos com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em centros de atenção especializados, assegurando cuidado contínuo e adaptado às necessidades.

- 1. 2. 4. 18.

  Redução de deslocamentos prolongados para capitais ou grandes centros, permitindo a familiares e cuidadores acompanhar mais de perto o tratamento.

- 1. 2. 4. 19.

  Externalidades positivas:

  - 1. 2. 4. 20.

    Maior integração de ações intersetoriais (saúde, assistência social, educação), ampliando a proteção social das populações vulneráveis.

  - 1. 2. 4. 21.

    Fomento de redes de apoio comunitárias, promovendo inclusão social e participação da sociedade civil no acompanhamento desses grupos.

1. 2. 4. 22.

Integração e modernização da gestão em saúde

- **1. 2. 4. 23.**

  Benefícios diretos:

  - 1. 2. 4. 24.

    Otimização dos recursos públicos, ao aprimorar processos de regulação de leitos, compras de insumos e gestão de pessoas, aumentando a transparência e controlando desperdícios.

  - 1. 2. 4. 25.

    Maior fluidez no fluxo de informações entre unidades de saúde, possibilitando continuidade do cuidado e rapidez na tomada de decisões.

- 1. 2. 4. 26.

  Externalidades positivas:

  - 1. 2. 4. 27.

    Fortalecimento de uma cultura de inovação no Estado, estimulando o desenvolvimento de tecnologias e soluções em saúde digital.

  - 1. 2. 4. 28.

    Potencial para cooperação com outras esferas de governo e setores, ampliando o impacto em políticas públicas correlatas (por exemplo, educação e segurança alimentar).

1. 2. 4. 29.

Estruturação de linhas de cuidado e protocolos clínicos

- **1. 2. 4. 30.**

  Benefícios diretos:

  - 1. 2. 4. 31.

Maior previsibilidade e consistência nos atendimentos, garantindo acompanhamento sistemático aos pacientes crônicos e reduzindo complicações evitáveis.

- 1. 2. 4. 32.

  Potencial elevação da qualidade da assistência materno-infantil, apoiando a saúde de gestantes, puérperas e recém-nascidos em todo o Estado.

- 1. 2. 4. 33.

Externalidades positivas:

- 1. 2. 4. 34.

  Integração efetiva entre diversos níveis de atenção (primário, secundário e terciário), favorecendo a cooperação entre profissionais de saúde.

- 1. 2. 4. 35.

  Redução gradual dos custos relativos a internações prolongadas e procedimentos de alta complexidade, dado o melhor controle clínico das condições crônicas.

Impacto global esperado:

Ao reunir essas iniciativas, o PROSUS PI reforça a capacidade do SUS de alcançar uma cobertura mais homogênea e resolutiva, priorizando as populações em maior vulnerabilidade e reduzindo desigualdades históricas entre as regiões de saúde. A expectativa é que, a médio e longo prazo, esses benefícios se consolidam em melhores índices de saúde e desenvolvimento social, tornando o Piauí referência na gestão efetiva de recursos e serviços públicos, em harmonia com os Objetivos Estratégicos nº 102, 111, 202 e 303 do PPA 2024-2027.

1. 3. **Objetivo**

(i) Objetivo Geral

O Programa tem como objetivo contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Estado do Piauí, por meio do fortalecimento da rede pública de serviços, garantindo mais acesso, qualidade e efetividade na atenção às demandas de saúde.

(ii) Objetivos Específicos

a) Ampliar e qualificar os serviços de média e alta complexidade, garantindo consultas, procedimentos especializados e exames em tempo oportuno.

Correlação:

- 1. 4.

  Componentes/Produtos: C.1 – Consolidação do Acesso e dos Serviços nas Redes de Atenção à Saúde (P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4, P.1.5).

- 1. 5.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: nº 102, 111.

- 1. 6.

  Indicador: 1 e 2

b) Fortalecer a rede hospitalar com reformas e ações sustentáveis que assegurem segurança e conforto a pacientes e profissionais.

Correlação:

- 1. 7.

  Componentes/Produtos: C.1 – Consolidação do Acesso e dos Serviços (P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4) e P.2.5, quando envolva estrutura sustentável.

- 1. 8.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: nº 111, 202.

- 1. 9.

  Indicador: 2

c) Consolidar linhas de cuidado e protocolos clínicos para doenças crônicas e saúde materno-infantil, promovendo acompanhamento contínuo e redução da morbimortalidade.

Correlação:

- 1. 10.

  Componentes/Produtos: C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação, sobretudo P.2.10 (Linhas de cuidado), P.2.7 (Capacitação) e outros correlatos.

- 1. 11.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: nº 102, 303.

- 1. 12.

  Indicador: 3, 4 e 5

d) Oferecer atendimento especializado e regionalizado para populações em situação de vulnerabilidade, com foco em idosos, pessoas com deficiência e TEA.

Correlação:

- 1. 13.

  Componentes/Produtos: C.3 – Fortalecer Modelos de Atenção e Cuidados (P.3.1) e P.1.5, quando policlínicas abrigarem serviços direcionados.

- 1. 14.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: nº 102, 111.

- 1. 15.

  Indicador: 6

e) Modernizar a gestão em saúde, adotando tecnologias de informação, sistemas de regulação e ações de educação permanente.

Correlação:

- 1. 16.

  Componentes/Produtos: C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação (P.2.1, P.2.2, P.2.3, P.2.4, P.2.6, P.2.7, P.2.8, P.2.9, P.2.10) e C.4 – Administração e Avaliação do Programa (P.4.1, P.4.2).

- 1. 17.

  Objetivos Estratégicos do PPA 2024-2027: nº 102, 303.

- 1. 18.

Indicador: 7

1. 19. **Indicadores**

1. 19. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: INDICADOR 7: Número anual de pessoas idosas, com deficiência intelectual e/ou com demandas em saúde mental com acompanhamento nos Centros de Referência

Descrição:
Este indicador mensura a quantidade de pessoas com 60 anos ou mais, com deficiência intelectual e/ou com demandas em saúde mental, atendidas nos Centros de Referência a serem implantados pelo programa. Esses centros prestarão atenção especializada, multiprofissional e integrada, com base em encaminhamentos da Atenção Primária à Saúde. O indicador reflete a ampliação da rede de cuidados regionais a populações vulneráveis, promovendo maior equidade no acesso e a continuidade do cuidado em saúde.

Fórmula de Cálculo:
Número absoluto de pessoas atendidas anualmente nos Centros de Referência, referenciadas pela Atenção Primária à Saúde

Objetivo Específico relacionado: d) Oferecer atendimento especializado e regionalizado para populações em situação de vulnerabilidade, com foco em idosos, pessoas com deficiência e TEA.

Objetivo Estratégico do PPA 2024–2027:

- 1. 19. 2.

  Objetivo Estratégico nº 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

- 1. 19. 3.

  Objetivo Estratégico nº 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em equipamentos sociais

Componente/Subcomponente/Produto relacionado:

- 1. 19. 4.

  Componente C.3 – Fortalecimento de Modelos de Atenção e Cuidados

  - 1. 19. 5.

    P.3.1 – Construção de Centros de Reabilitação e Centros de Referência para Idosos, Pessoas com Deficiência Intelectual e para Apoio à Saúde Mental

Coerência com os Objetivos:
A implantação de Centros de Referência para atendimento de idosos, pessoas com deficiência intelectual e usuários da saúde mental preenche uma lacuna crítica nos serviços especializados regionais. Trata-se de uma ação com alto impacto social, que reduz desigualdades, fortalece as Redes de Atenção à Saúde e promove o cuidado continuado a populações historicamente negligenciadas, com potencial de replicabilidade em outras regiões.

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

- 1. 19. 6.

  Número total de atendimentos realizados nos Centros de Referência por faixa etária e perfil (idoso, PCD, saúde mental)

- 1. 19. 7.

  Registros de referência e contrarreferência oriundos da Atenção Primária

- 1. 19. 8.

  Cadastramento dos pacientes em sistemas locais e estaduais de informação em saúde

- 1. 19. 9.

  Capacidade instalada e cobertura regional dos centros

Aplicação do Modelo SMART:

- 1. 19. 10.

  S (Específico): Aumentar o número de atendimentos especializados em saúde do idoso, deficiência intelectual e saúde mental

- 1. 19. 11.

  M (Mensurável): Quantidade anual de pessoas atendidas nos Centros de Referência

- 1. 19. 12.

  A (Atingível): A meta é baseada na capacidade dos centros a serem implantados, com infraestrutura e equipe multiprofissional prevista no projeto

- 1. 19. 13.

  R (Relevante): O indicador está diretamente relacionado ao fortalecimento da atenção especializada e regionalizada para populações vulneráveis

- 1. 19. 14. T (Temporal): Meta a ser atingida até 2030

Meta:
Linha de Base:
0 (ano base: 2024 – não há Centros de Referência implantados atualmente)

Meta do Projeto até 2030:
9.720 pessoas alvo atendidas anualmente

1. 19. 15. **Informações do 2° indicador:**
Nome: INDICADOR 8: Percentual da Rede de Média e Alta Complexidade com Prontuário Eletrônico 100% Implantado

Descrição:
Este indicador mede a proporção das unidades da rede pública estadual de média e alta complexidade (hospitais regionais, hospitais estaduais, Unidades de Pronto Atendimento – UPAs e Policlínicas) que possuem o sistema de prontuário eletrônico implantado integralmente. A implantação do prontuário eletrônico permite a digitalização completa das informações clínicas, promovendo integração entre níveis de atenção, maior eficiência no cuidado ao paciente, rastreabilidade dos atendimentos e apoio à gestão hospitalar.

Fórmula de Cálculo:
(Número de unidades com prontuário eletrônico 100% implantado / Total de unidades da rede estadual de média e alta complexidade) × 100

Total de Unidades Consideradas (2025):
32 unidades:

- 1. 19. 16.

  5 UPAs

- 1. 19. 17.

  5 Policlínicas

- 1. 19. 18.

  11 Hospitais Regionais

- 1. 19. 19.

  11 Hospitais Estaduais

Objetivos Específicos Relacionados:

- 1. 19. 20.

  Objetivo específico e): Modernizar a gestão em saúde, adotando tecnologias de informação, sistemas de regulação e ações de educação permanente.

Objetivos Estratégicos do PPA 2024–2027:

- 1. 19. 21.

  Objetivo Estratégico nº 303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo

- 1. 19. 22.

  Objetivo Estratégico nº 102: Ampliar o acesso à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS

Componente/Subcomponente/Produto:

- 1. 19. 23.

  Componente C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação

  - 1. 19. 24.

    P.2.1 – Custeio dos programas de saúde digital

  - 1. 19. 25.

    P.2.4 – Integração de sistemas e desenvolvimento de aplicativos

Coerência com os Objetivos:
O fortalecimento da digitalização na rede de média e alta complexidade permite integração sistêmica, melhora da resolutividade clínica, eficiência administrativa e suporte à tomada de decisão baseada em dados. A implantação ampla do prontuário eletrônico constitui uma ação estratégica de modernização da saúde, com alto potencial de replicabilidade e impacto em regiões com baixa informatização.

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

- 1. 19. 26.

  Relatórios das unidades com prontuário eletrônico implantado

- 1. 19. 27.

  Validação de funcionamento pleno do sistema em todas as áreas clínicas da unidade

- 1. 19. 28.

  Dados de interoperabilidade entre os níveis de atenção e sistemas estaduais

Aplicação do Modelo SMART:

- 1. 19. 29.

  S (Específico): Implantar prontuário eletrônico integral em unidades da rede estadual de média e alta complexidade

- 1. 19. 30.

  M (Mensurável): Percentual de unidades com prontuário implantado

- 1. 19. 31.

  A (Atingível): Meta de 29 unidades em 5 anos, compatível com capacidade técnica e financeira prevista

- 1. 19. 32.

  R (Relevante): Impacta diretamente na modernização da rede pública de saúde e na qualidade do cuidado ao paciente

- 1. 19. 33.

  T (Temporal): Meta prevista para o quinto ano do projeto (2030)

Meta:
Considerando um total de 32 unidades de saúde (UPAs, Policlínicas, Hospitais Regionais, Hospitais Estaduais) em 2025:

Linha de Base (2025):
Sendo 7 unidades com prontuário eletrônico implantado, representando 22%.

Meta do Projeto até 2030:
29 unidades com prontuário eletrônico 100% implantado, representando 91%

1. 19. 34. **Informações do 3° indicador:**
Nome: INDICADOR 9: Ampliar o número de consultas de telemedicina realizadas anualmente no Programa Saúde Digital

Descrição:
Este indicador mensura o volume de atendimentos clínicos realizados por meio da plataforma de telemedicina do Programa Saúde Digital, considerando todas as modalidades de consultas (acolhimento, acompanhamento, avaliação especializada e suporte diagnóstico) realizadas de forma remota. O aumento na quantidade de consultas por telemedicina reflete a ampliação do acesso a serviços especializados, especialmente em regiões com escassez de oferta presencial, e representa um avanço estratégico na modernização da gestão do SUS.

Fórmula de Cálculo:
Número absoluto de consultas de telemedicina realizadas no ano
(Fonte: Plataforma do Programa Saúde Digital / SESAPI)

Objetivo Específico Relacionado: e)

Objetivo Estratégico do PPA 2024–2027:

- 1. 19. 35.

  OE nº 303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

- 1. 19. 36.

OE nº 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Componente/Subcomponente/Produto relacionado:
Componente C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação
P.2.1 – Custeio dos Programas de Saúde Digital Implementados pela SESAPI

Coerência com os Objetivos:
A ampliação do número de consultas por telemedicina contribui diretamente para a democratização do acesso aos serviços de saúde, reduzindo desigualdades territoriais e superando barreiras logísticas e econômicas de deslocamento. A expansão do Programa Saúde Digital representa uma solução altamente eficiente, escalável e replicável, com impactos transformadores na organização das redes de atenção à saúde.

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

- 1. 19. 37.

  Relatórios mensais da plataforma de telemedicina (SESAPI)

- 1. 19. 38.

  Número total de consultas por modalidade (clínica geral, especialidades, saúde mental, etc.)

- 1. 19. 39.

  Abrangência regional dos atendimentos

- 1. 19. 40.

  Perfil demográfico dos pacientes atendidos

Aplicação do Modelo SMART:

- 1. 19. 41.

  S (Específico): Aumentar o número de consultas de telemedicina anuais no Programa Saúde Digital do Piauí

- 1. 19. 42.

  M (Mensurável): Contagem anual de consultas realizadas (número absoluto)

- 1. 19. 43.

  A (Atingível): A meta foi definida com base no histórico de uso e na capacidade de expansão da rede digital

- 1. 19. 44.

  R (Relevante): O indicador está diretamente relacionado à ampliação do acesso e à inovação tecnológica no SUS

- 1. 19. 45.

  T (Temporal): A meta deve ser atingida até o ano de 2030, último ano de vigência do projeto.

Meta:
Linha de Base:
48.916 consultas no ano de 2024

Meta do Projeto até 2030:
78.779,71 consultas por ano

1. 19. 46. **Informações do 4° indicador:**
Nome: INDICADOR 1: Número de cirurgias eletivas nas 4 Macrorregiões de Saúde no ano em relação ao anterior aprovadas no SIHSUS

Descrição:
O número de cirurgias eletivas na Macrorregião é um indicador que mensura a evolução da capacidade do sistema de saúde em ofertar procedimentos cirúrgicos planejados, refletindo a ampliação da cobertura assistencial e a eficiência dos serviços de média e alta complexidade. Esse indicador expressa a variação entre o total de cirurgias eletivas realizadas no ano atual e no ano anterior, sendo calculado pela seguinte fórmula:

Fórmula de cálculo:

- 1. 19. 47.

  (Total de cirurgias eletivas do ano atual - Total de cirurgias eletivas do ano anterior) / Total de cirurgias eletivas do ano anterior.

- 1. 19. 48.

  Unidade de medida: Número absoluto.

A ampliação do acesso a cirurgias eletivas impacta diretamente a qualidade de vida da população, reduzindo o tempo de espera para procedimentos necessários e prevenindo a evolução de doenças que podem gerar complicações mais graves. Além disso, a expansão da oferta cirúrgica diminui as desigualdades regionais no acesso à saúde, promovendo um sistema mais equitativo e eficiente.

A meta estabelecida no âmbito do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) prevê um aumento expressivo no volume de cirurgias eletivas, passando de 24.538 cirurgias em 2024 para 43.576 cirurgias até 2030, consolidando a reorganização dos serviços cirúrgicos no estado.

O monitoramento desse indicador será realizado por meio do Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIHSUS), permitindo a análise da evolução do desempenho das unidades hospitalares e subsidiando ações para ajustes na oferta cirúrgica.

Modelo SMART:

- 1. 19. 49.

  Específico (S): Mede o aumento do número absoluto de cirurgias eletivas realizadas no SUS na Macrorregião.

- 1. 19. 50.

  Mensurável (M): Os dados são registrados no SIHSUS e podem ser acompanhados anualmente.

- 1. 19. 51.

  Atingível (A): A meta de 43.576 cirurgias até 2030 está baseada na ampliação da capacidade instalada e no fortalecimento da gestão hospitalar.

- 1. 19. 52.

  Relevante (R): Impacta diretamente a redução das filas de espera e melhora a resolutividade dos serviços de saúde pública.

- 1. 19. 53.

  Temporal (T): Monitoramento anual, com meta final estabelecida para 2030.

Alinhamento:

- 1. 19. 54.

  Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: nº 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 19. 55.

  Objetivo Específico: a) Ampliar e qualificar os serviços de média e alta complexidade, garantindo consultas, procedimentos especializados e exames em tempo oportuno.

- 1. 19. 56.

  Componente/Subcomponente/Produto: C.1 – Consolidação do Acesso e dos Serviços nas Redes de Atenção à Saúde (P.1.1, P.1.2, P.1.3, P.1.4, P.1.5).

Meta:
Aumentar em 100% o número de cirurgias eletivas nas Macrorregiões Semiárido, Cerrados e Litoral e 60% na Macrorregião Meio Norte do Estado do Piauí, passando de 33.518 em 2024 para 43.576 até 2027, conforme PPA 2024-2027 e para 69.659 até 2030, garantindo maior acesso da população aos procedimentos cirúrgicos e reduzindo os tempos de espera.

1. 19. 57. **Informações do 5° indicador:**
Nome: INDICADOR 2: Tempo de espera de 60 dias para Cirurgias Eletivas por Macrorregião de Saúde do Estado

Descrição:
Este indicador mede o tempo médio, expresso em dias, entre a data de indicação médica e a data de realização da cirurgia eletiva, por macrorregião de saúde. Representa um parâmetro fundamental para avaliar a eficiência do sistema de regulação e a capacidade instalada da rede hospitalar estadual.

Trata-se de uma métrica crítica para o monitoramento da qualidade da assistência, do planejamento da oferta de serviços e da gestão das filas de espera para cirurgias eletivas. Reduções nesse tempo indicam maior resolutividade, acesso oportuno ao cuidado e gestão eficaz da demanda reprimida.

Fórmula de cálculo: Tempo médio de espera (dias) = ?(Data da cirurgia ? Data da indicação médica)

Coerência com os objetivos:
O indicador está diretamente relacionado à melhoria da oferta e à gestão da capacidade instalada dos serviços hospitalares. A redução do tempo de espera contribui para aumentar a resolutividade do SUS, reduz a judicialização, melhora a experiência do usuário e otimiza o uso de recursos públicos. A gestão eficiente da fila de cirurgias eletivas exige infraestrutura hospitalar adequada, equipes capacitados e sistemas de regulação transparentes e digitais – todos contemplados no escopo do PROSUS PI.

Dados a serem coletados:

- 1. 19. 58.

  Data da indicação da cirurgia (prescrição médica com CID e tipo de procedimento)

- 1. 19. 59.

  Data de realização da cirurgia

- 1. 19. 60.

  Tempo total de espera por paciente

- 1. 19. 61.

  Agrupamento por macrorregião de saúde

- 1. 19. 62.

  Fonte primária: Sistema de Regulação Estadual e SIH-SUS

Modelo de definição:
Este indicador segue a lógica SMART:

- 1. 19. 63.

  Específico (tempo de espera por cirurgia eletiva);

- 1. 19. 64.

  Mensurável (minutos e segundos);
  Atingível (viável com ações do PROSUS PI);

- 1. 19. 65.

  Relevante (relacionado diretamente à experiência do paciente e ao desempenho da rede);

- 1. 19. 66.

  Temporal (monitorável anualmente, com meta para 2030).

Alinhamento:

- 1. 19. 67.

  Objetivo Estratégico do PPA: 102

- 1. 19. 68.

  Objetivo Específico: a) e b)

- 1. 19. 69.

  Componente/Subcomponente/Produto:
  C.1 – Consolidação do Acesso e dos Serviços nas Redes de Atenção à Saúde P.1.1 – Reforma e requalificação da infraestrutura hospitalar; P.1.2 – Equipagem de hospitais;

Meta:
Linha de Base (2023):

- 1. 19. 70.

  Macrorregião Cerrados - 67 dias

- 1. 19. 71.

  Macrorregião Semiárido - 74 dias

- 1. 19. 72.

  Macrorregião Meio Norte - 193 dias

- 1. 19. 73.

  Macrorregião Litoral - 77 dias

Meta (2030): Redução sustentada para tempo médio de 60 dias corridos.

1. 19. 74. **Informações do 6° indicador:**
Nome: INDICADOR 3: Mortalidade infantil neonatal no Estado do Piauí (Indicador chave nacional do Objetivo Estratégico 102 do PPA)

Descrição:
A taxa de mortalidade infantil neonatal mede o número de óbitos de crianças com idade entre 0 e 27 dias de vida por mil nascidos vivos no Estado do Piauí. Esse indicador é fundamental para monitorar a qualidade dos serviços de saúde materno-infantil e avaliar a efetividade das políticas públicas voltadas para a redução da mortalidade infantil, em especial a neonatal. A meta estabelecida busca a redução da taxa de mortalidade neonatal, alinhada ao Objetivo Estratégico nº 102 do PPA 2024-2027, que visa ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

A redução da mortalidade neonatal é um reflexo da melhoria na assistência pré-natal, da qualificação dos serviços de parto e pós-parto e da expansão do acesso a cuidados neonatais adequados. Para garantir o monitoramento eficaz,

serão coletados e analisados dados oficiais de registros de nascidos vivos e óbitos neonatais, conforme metodologia padronizada pelo Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) e pelo Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), ambos do Ministério da Saúde.

O indicador segue o modelo SMART:

- 1. 19. 75.

  S (Específico): Mede a taxa de mortalidade neonatal, fator crucial para avaliar a qualidade dos serviços de saúde materno-infantil.

- 1. 19. 76.

  M (Mensurável): Expressa-se em casos por mil nascidos vivos, garantindo precisão na coleta e análise dos dados.

- 1. 19. 77.

  A (Atingível): A meta de redução é baseada em evidências e experiências de estados que implementaram políticas similares com êxito.

- 1. 19. 78.

  R (Relevante): Relaciona-se diretamente à melhoria da saúde infantil e ao fortalecimento do SUS, impactando a qualidade de vida da população.

- 1. 19. 79.

  T (Temporal): Prevê a redução da taxa do ano de linha base 2024 até 2030.

Os dados a serem coletados para acompanhar a implementação do programa incluem:

- 1. 19. 80.

  Número de óbitos neonatais registrados.

- 1. 19. 81.

  Total de nascidos vivos no Estado do Piauí.

- 1. 19. 82.

  Indicadores de acesso e qualidade da assistência pré-natal e neonatal.

- 1. 19. 83.

  Evolução das condições estruturais e operacionais das unidades hospitalares de referência para partos de alto risco.

Alinhamento:

- 1. 19. 84.

  Objetivo Estratégico do PPA: nº 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 19. 85.

  Objetivo Específico: c) Consolidar linhas de cuidado e protocolos clínicos para doenças crônicas e saúde materno-infantil, promovendo acompanhamento contínuo e redução da morbimortalidade.

- 1. 19. 86.

  Componente/Subcomponente/Produto: C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação, especialmente P.2.10 (Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno-infantil).

Meta:
Reduzir a taxa de mortalidade infantil neonatal no Estado do Piauí de 9,86 (2024) para 9,74 (2030) casos por 1.000 nascidos vivos ao final do período de implementação do programa, por meio da qualificação da atenção materno-infantil e da expansão do acesso a serviços especializados.

1. 19. 87. **Informações do 7° indicador:**
Nome: INDICADOR 4: Razão de Mortalidade Materna (Indicador Chave Nacional do Objetivo Estratégico 102 do PPA)

Descrição:
A Razão de Mortalidade Materna (RMM) é um indicador fundamental para monitorar a qualidade da atenção materno-infantil e a efetividade das políticas de saúde voltadas à redução de óbitos evitáveis entre gestantes, parturientes e puérperas. Ele expressa a relação entre o número de óbitos maternos e o total de nascidos vivos em determinada localidade e período, padronizado por 100.000 nascidos vivos (NV).

A redução da mortalidade materna está diretamente associada à ampliação do acesso e qualificação da assistência pré-natal, ao fortalecimento das redes de atenção obstétrica e neonatal, e à melhoria na gestão dos serviços de saúde. Assim, este indicador reflete não apenas o desempenho da rede assistencial, mas também a efetividade das ações para prevenção, diagnóstico precoce e tratamento de complicações gestacionais.

A meta estabelecida no âmbito do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) visa reduzir a Razão de Mortalidade Materna de 88,25 para 74,05 por 100.000 NV, alinhando-se às diretrizes nacionais e internacionais para o enfrentamento da mortalidade materna, em consonância com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e com o Objetivo Estratégico 102 do PPA 2024-2027.

A coleta e monitoramento desse indicador exigem a sistematização de dados oriundos do Sistema de Informação sobre Mortalidade (SIM) e do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC), além de investigações sobre as causas de morte materna realizadas por comitês estaduais e municipais. O acompanhamento contínuo da RMM permite avaliar a efetividade das intervenções e propor ajustes para garantir maior segurança na assistência materno-infantil.

Modelo SMART:

- 1. 19. 88.

  Específico (S): Mede a razão entre óbitos maternos e nascidos vivos, refletindo diretamente a qualidade da assistência obstétrica e neonatal.

- 1. 19. 89.

  Mensurável (M): Acompanhado por meio de registros do SIM e SINASC, permitindo quantificação precisa.

- 1. 19. 90.

  Atingível (A): A meta de redução para 74,05 por 100.000 NV está alinhada com esforços nacionais e internacionais para redução da mortalidade materna.

- 1. 19. 91.

  Relevante (R): Indica impacto direto das políticas públicas voltadas à atenção materno-infantil e à ampliação do acesso a serviços obstétricos de qualidade.

- 1. 19. 92.

  Temporal (T): Deve ser monitorado anualmente para verificar a progressão da redução da mortalidade dentro do período de vigência do PPA 2024-2027. Linha de base no ano 2024 é de 83,17 e meta em 2030 é de 30 mortes a cada 100 mil nascidos vivos, conforme os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), das Nações Unidas.

Alinhamento:

- 1. 19. 93.

  Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: nº 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 19. 94.

  Objetivo Específico: c) Consolidar linhas de cuidado e protocolos clínicos para doenças crônicas e saúde materno-infantil, promovendo acompanhamento contínuo e redução da morbimortalidade.

- 1. 19. 95.

  Componente/Subcomponente/Produto: C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação (P.2.10 – Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno-infantil).

Meta:
Reduzir a Razão de Mortalidade Materna de 83,17 (2024) para 30,00 (em 2030) por 100.000 nascidos vivos, até o final do período de execução do PPA 2024-2027, por meio do fortalecimento da assistência pré-natal, qualificação dos serviços obstétricos e fortalecimento da vigilância em saúde materna.

1. 19. 96. **Informações do 8° indicador:**
Nome: INDICADOR 5: Prevalência da desnutrição em crianças menores de 5 anos (%) (Indicador Chave Nacional do Objetivo Estratégico 101 do PPA)

Descrição:
Este indicador mede a proporção de crianças menores de 5 anos com déficit nutricional, considerando a baixa estatura para a idade (desnutrição crônica), com base nas diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e nos dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). É um indicador chave para o enfrentamento da insegurança alimentar e nutricional, diretamente relacionado ao desenvolvimento infantil e à redução da mortalidade infantil.

Fórmula de Cálculo:
(Número de crianças menores de 5 anos com diagnóstico de desnutrição / Total de crianças menores de 5 anos avaliadas) × 100

Objetivos Específicos Relacionados:

- 1. 19. 97.

  c) Consolidar linhas de cuidado e protocolos clínicos para doenças crônicas e saúde materno-infantil, promovendo acompanhamento contínuo e redução da morbimortalidade.

- 1. 19. 98.

  d) Oferecer atendimento especializado e regionalizado para populações em situação de vulnerabilidade, com foco em idosos, pessoas com deficiência e TEA.

Objetivo Estratégico do PPA 2024–2027:

- 1. 19. 99.

  Objetivo Estratégico nº 101: Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social.

- 1. 19. 100.

  Componente/Subcomponente/Produto relacionado:
  Componente C.1: Consolidação do Acesso e dos Serviços (P.1.3 – Ampliação do complexo materno-infantil)

  - 1. 19. 101.

    Componente C.2: Aprimoramento da Gestão e Inovação (P.2.10 – Linhas de cuidado para saúde materno-infantil)

  - 1. 19. 102.

    Componente C.3: Fortalecimento de Modelos de Atenção e Cuidados

Coerência com os Objetivos:
A redução da prevalência da desnutrição infantil está diretamente vinculada à ampliação do acesso aos serviços de saúde especializados, à integração entre atenção primária e especializada, à estruturação da vigilância nutricional e à qualificação do cuidado com a primeira infância. A erradicação da desnutrição exige uma abordagem intersetorial e sustentada, com impactos diretos na equidade em saúde e na superação da pobreza extrema.

Dados a Serem Coletados para Monitoramento:

- 1. 19. 103.

  Total de crianças menores de 5 anos acompanhadas no SISVAN.

- 1. 19. 104.

  Número de crianças com diagnóstico de desnutrição (com base no indicador estatura/idade).

- 1. 19. 105.

  Dados de cobertura da atenção nutricional e ações intersetoriais em alimentação e saúde infantil.

- 1. 19. 106.

  Registros de atendimentos em centros de referência ou unidades com linha de cuidado materno-infantil.

- 1. 19. 107.

  Ações de suplementação, alimentação saudável e educação alimentar no âmbito do programa.

Aplicação do Modelo SMART:

- 1. 19. 108.

  S (Específico): Reduzir a desnutrição infantil em crianças menores de 5 anos no Estado do Piauí.

- 1. 19. 109.

  M (Mensurável): Percentual de crianças desnutridas registrado no SISVAN.

- 1. 19. 110.

  A (Atingível): Alinhado à ampliação da oferta de serviços e à modernização da rede de atenção.

- 1. 19. 111.

  R (Relevante): Reflete condição crítica de saúde pública e está alinhado ao Objetivo Estratégico 101 do PPA

- 1. 19. 112.

  T (Temporal): Meta estabelecida para o ano de 2030.

Meta:
Linha de Base:
6,06% (Fonte: SISVAN/2024)

Meta do Plano Estadual de Saúde (PES) 2024–2027:
Reduzir para 6,92%

Meta do Projeto até 2030:
Erradicação da desnutrição – alcançar 0%

1. 19. 113. **Informações do 9° indicador:**
Nome: INDICADOR 6: Taxa de Mortalidade Geral dos leitos clínicos - Censo Hospitalar DUDOH/SUGMAC/SESAPI

Descrição:
A Taxa de Mortalidade Geral dos Leitos Clínicos mede a proporção de óbitos ocorridos em pacientes internados em relação ao total de pacientes que tiveram alta hospitalar (por cura, transferência ou óbito) dentro de um determinado

período. Esse indicador é essencial para avaliar a qualidade da assistência hospitalar, refletindo a eficácia dos protocolos clínicos, a resolutividade dos serviços e a segurança do paciente.

Fórmula de cálculo:

- 1. 19. 114.

  (Número de óbitos de pacientes internados / Número total de saídas hospitalares) x 100.

- 1. 19. 115.

  Unidade de medida: Percentual (%).

A meta estabelecida no âmbito do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) busca reduzir essa taxa de 5,00% para 1,00%, garantindo uma melhoria na assistência hospitalar, ampliando a adoção de protocolos clínicos baseados em evidências e promovendo práticas de segurança do paciente.

O monitoramento desse indicador será realizado a partir dos dados do Censo Hospitalar DUDOH/SUGMAC/SESAPI, assegurando o acompanhamento contínuo da taxa de mortalidade e a avaliação da efetividade das medidas adotadas para sua redução.

Modelo SMART:

- 1. 19. 116.

  Específico (S): Mede a relação entre óbitos e altas hospitalares, refletindo a qualidade da assistência.

- 1. 19. 117.

  Mensurável (M): Extraído do Censo Hospitalar DUDOH/SUGMAC/SESAPI, com monitoramento contínuo.

- 1. 19. 118.

  Atingível (A): A meta de redução para 1% é fundamentada em ações de melhoria da assistência hospitalar e adoção de protocolos de segurança.

- 1. 19. 119.

  Relevante (R): Impacta diretamente a segurança do paciente e a eficácia dos serviços clínicos.

- 1. 19. 120.

  Temporal (T): Monitoramento anual, com linha de base em 2024 e meta final estabelecida para 2030.

Alinhamento:

- 1. 19. 121.

  Objetivo Estratégico do PPA 2024-2027: nº 102 – Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 19. 122.

  Objetivo Específico: c) Consolidar linhas de cuidado e protocolos clínicos para doenças crônicas e saúde materno-infantil, promovendo acompanhamento contínuo e redução da morbimortalidade.

- 1. 19. 123.

  Componente/Subcomponente/Produto: C.2 – Aprimoramento dos Processos de Gestão e Inovação (P.2.10 – Implementação de linhas de cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e materno-infantil, P.2.7 – Capacitação e Educação Permanente).

Meta:

Reduzir a Taxa de Mortalidade Geral dos Leitos Clínicos de 5,00% em 2024 para 1,00% até 2030, por meio da adoção de protocolos clínicos mais eficazes, capacitação contínua das equipes de saúde e melhoria da estrutura hospitalar.

1. 20. **Componentes**

1. 20. 1. **Informações do 1° componente:**

Nome: CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO

Valor estimado em Real (BRL): 451.045.140,00

Descrição:

O Componente 1 visa à expansão, modernização e melhoria da infraestrutura da rede de atenção à saúde no Estado do Piauí, promovendo a requalificação de unidades hospitalares, a ampliação da oferta de serviços especializados e o fortalecimento da capacidade instalada. Esse fortalecimento abrange tanto a infraestrutura física quanto a adoção de tecnologias inovadoras para otimizar a gestão dos serviços de saúde. A estratégia contempla a reforma e requalificação de hospitais regionais, a ampliação da rede de atendimento materno-infantil, o fortalecimento da Rede de Urgência e Emergência e a expansão das policlínicas e centrais de exames para reduzir vazios assistenciais e melhorar a resolutividade da Atenção Primária.

Objetivo do Componente: Garantir a ampliação do acesso à saúde pública com qualidade e eficiência, promovendo um modelo de atenção que assegure atendimento oportuno e resolutivo para a população piauiense, com foco na descentralização da assistência e na equidade do acesso a serviços de média e alta complexidade.

Relação com a Solução Proposta: Esse componente responde diretamente ao problema da falta de acesso a serviços especializados e hospitalares, que compromete a efetividade do SUS no estado. A requalificação das unidades de saúde e a modernização dos equipamentos possibilitam maior oferta de leitos, cirurgias e exames, reduzindo os tempos de espera e os deslocamentos de pacientes entre municípios. A ampliação das portas de entrada para atendimento de urgência e emergência fortalece a capacidade de resposta do sistema às demandas de saúde.

Relação com os Resultados Esperados: A implementação desse componente resultará na melhoria da cobertura assistencial e na qualificação dos serviços ofertados, permitindo um aumento no número de leitos hospitalares disponíveis, a redução do tempo de espera para cirurgias eletivas e exames diagnósticos, e a melhoria dos indicadores de saúde materno-infantil. Além disso, contribuirá para a modernização da rede hospitalar, garantindo ambientes seguros, eficientes e humanizados para pacientes e profissionais.

Produtos Vinculados:

- 1. 20. 2.

  P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de 10 hospitais de regiões de saúde.

- 1. 20. 3.

  P.1.2 10 Hospitais Equipados e Mobiliados.

- 1. 20. 4.

  P.1.3 Ampliação do complexo materno-infantil.

- 1. 20. 5.

  P.1.4 Ampliação de serviços de emergência (UPA/pronto socorro).

- 1. 20. 6.

  P.1.5 Ampliação da rede de central de exames/policlínicas.

Alinhamento com o PPA 2024-2027:

- 1. 20. 7.

  Objetivo Estratégico nº 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 20. 8.

Objetivo Estratégico nº 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

- 1. 20. 9.

  Objetivo Estratégico nº 202: Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 1 - Consolidação do Acesso e dos Serviços nas Redes de Atenção à Saúde - Fortalecimento tem como objetivo aprimorar a infraestrutura hospitalar e ampliar a oferta de serviços de média e alta complexidade no estado do Piauí. A implementação desse componente abrange a requalificação física e tecnológica de unidades de saúde estratégicas, garantindo maior eficiência no atendimento à população e reduzindo desigualdades regionais no acesso aos serviços de saúde.

Os produtos listados a seguir detalham as intervenções específicas planejadas no âmbito do Componente 1.

P.1.1 Reforma e requalificação da infraestrutura de hospitais de regiões de saúde

- 1. 20. 10.

  Descrição: Realização de reformas estruturais e modernização da infraestrutura de 10 hospitais regionais, garantindo a ampliação da capacidade instalada e a melhoria da qualidade da assistência hospitalar.

- 1. 20. 11.

  Objetivo: Fortalecer a rede hospitalar pública do estado, assegurando condições adequadas para atendimento de média e alta complexidade.

- 1. 20. 12.

  Resultados esperados: Aumento da segurança estrutural, ampliação da capacidade de atendimento hospitalar e modernização dos serviços prestados à população.

P.1.2 Hospitais Equipados e Mobiliados

- 1. 20. 13.

  Descrição: Aquisição de equipamentos modernos e mobiliários para 10 hospitais regionais, visando à atualização tecnológica e à qualificação da assistência hospitalar.

- 1. 20. 14.

  Objetivo: Garantir a adequação dos hospitais às exigências assistenciais e regulatórias, proporcionando melhorias na resolutividade dos serviços.

- 1. 20. 15.

  Resultados esperados: Redução do tempo de espera por exames e procedimentos especializados, aumento da eficiência hospitalar e qualificação da assistência ao paciente.

P.1.3 Ampliação do Complexo Materno-Infantil

- 1. 20. 16.

  Descrição: Expansão e estruturação da rede de atenção materno-infantil em quatro macrorregiões do estado, descentralizando serviços e promovendo um atendimento mais acessível e humanizado para gestantes e recém-nascidos.

- 1. 20. 17.

  Objetivo: Melhorar os indicadores de saúde materno-infantil e fortalecer a Rede de Atenção Materna e Infantil no estado.

- 1. 20. 18.

  Resultados esperados: Aumento do número de leitos obstétricos e neonatais, ampliação do acesso ao parto humanizado e melhoria dos indicadores de mortalidade materna e infantil.

P.1.4 Ampliação de Serviços de Emergência (UPA/Pronto Socorro)

- 1. 20. 19.

  Descrição: Construção e expansão de 3 unidades de pronto atendimento e serviços de emergência em hospitais estratégicos do estado, garantindo melhor resposta à demanda por atendimento imediato.

- 1. 20. 20.

  Objetivo: Fortalecer a Rede de Urgência e Emergência, ampliando a cobertura de atendimento pré-hospitalar e hospitalar.

- 1. 20. 21.

  Resultados esperados: Redução do tempo de espera por atendimento emergencial, maior descentralização dos serviços de urgência e aumento da capacidade de resposta a situações críticas.

P.1.5 Ampliação da Rede de Central de Exames/Policlínicas

- 1. 20. 22.

  Descrição: Expansão e modernização da rede de 4 policlínicas/centrais de exames, promovendo acesso mais ágil e eficiente a consultas e exames especializados.

- 1. 20. 23.

  Objetivo: Reduzir o tempo de espera para diagnóstico e tratamento de diversas patologias, garantindo o seguimento adequado ao diagnóstico inicial realizado na Atenção Primária à Saúde.

- 1. 20. 24.

  Resultados esperados: Maior oferta de consultas especializadas e exames diagnósticos, diminuição da sobrecarga em hospitais e melhoria na resolutividade da Atenção Primária.

Os produtos vinculados ao Componente 1 atuam diretamente na melhoria da infraestrutura, na ampliação dos serviços especializados e no fortalecimento da rede pública hospitalar do Piauí. A execução dessas ações contribuirá significativamente para a qualificação da assistência à saúde, aumentando a capacidade de resposta do sistema de saúde estadual e garantindo melhor acesso e qualidade para a população.

1. 20. 25. **Informações do 2° componente:**
Nome: APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO
Valor estimado em Real (BRL): 329.554.680,00

Descrição:
O Componente 2 tem como objetivo fortalecer a capacidade institucional do sistema de saúde do Estado do Piauí, modernizando processos de gestão, inovação tecnológica e digitalização dos serviços. As ações previstas incluem o desenvolvimento e ampliação de sistemas inteligentes para otimização da logística de suprimentos, integração de sistemas de regulação, fortalecimento da saúde digital e aprimoramento da formação dos profissionais da rede estadual de saúde.

O aprimoramento dos processos de gestão e inovação visa aumentar a eficiência na alocação de recursos, melhorar a qualidade da prestação de serviços de saúde e reduzir desperdícios, garantindo uma administração mais transparente e eficaz dos serviços públicos.

Objetivo do Componente: Promover a modernização e inovação na gestão da saúde pública estadual, garantindo maior eficiência nos processos administrativos, na regulação de serviços, na integração de dados e no fortalecimento da capacidade técnica dos profissionais de saúde, com foco na ampliação da transformação digital e na melhoria contínua dos serviços.

Relação com a Solução Proposta: Este componente aborda desafios críticos da gestão da saúde, como a fragmentação de informações, dificuldades na logística de insumos e regulação de leitos, e a necessidade de capacitação contínua dos profissionais. A digitalização e integração de sistemas contribuirão para a melhoria da eficiência operacional e a otimização dos recursos disponíveis, fortalecendo a governança e a transparência na gestão pública da saúde.

Relação com os Resultados Esperados: A implementação do Componente 2 possibilitará maior eficiência na gestão hospitalar, redução de tempos de espera para atendimento, otimização da cadeia de suprimentos e maior integração dos serviços de saúde. Além disso, espera-se um aumento na qualidade da formação e capacitação dos profissionais de saúde, resultando em uma melhor prestação de serviços à população.

Alinhamento com o PPA 2024-2027:

- 1. 20. 26.

  Objetivo Estratégico nº 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 20. 27.

  Objetivo Estratégico nº 303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 2 tem como objetivo modernizar e fortalecer a gestão da saúde pública no Estado do Piauí, promovendo maior eficiência operacional, integração digital, qualificação profissional e certificação da qualidade hospitalar. As intervenções deste componente visam reduzir gargalos administrativos e aprimorar a logística, o controle e a regulação dos serviços de saúde, garantindo maior transparência e eficiência na alocação de recursos.

Os produtos abaixo detalham as ações estratégicas planejadas dentro do Componente 2.

P.2.1 Custeio dos Programas de Saúde Digital Implementados pela SESAPI

- 1. 20. 28.

  Descrição: Financiamento e expansão das iniciativas de saúde digital no estado, incluindo telemedicina, prontuário eletrônico, sistemas de gestão hospitalar e integração digital dos serviços de saúde.

- 1. 20. 29.

  Objetivo: Ampliar o acesso da população aos serviços digitais de saúde, garantindo maior eficiência no monitoramento e acompanhamento dos pacientes.

- 1. 20. 30.

  Resultados esperados: Redução do tempo de espera para atendimentos, maior interoperabilidade dos sistemas e otimização da gestão de informações em saúde.

P.2.2 Construção de Central de Armazenamento e Centro de Controle de Insumos e Medicamentos

- 1. 20. 31.

  Descrição: Implantação de uma central moderna para gestão e distribuição eficiente de insumos e medicamentos no estado.

- 1. 20. 32.

  Objetivo: Melhorar o controle de estoques, reduzir desperdícios e garantir a disponibilidade de insumos em todas as unidades de saúde.

- 1. 20. 33.

  Resultados esperados: Diminuição de desabastecimento em unidades hospitalares e otimização dos processos de compras e distribuição.

P.2.3 Construção e Equipagem de Nova Central de Regulação

- 1. 20. 34.

  Descrição: Criação de uma estrutura física e tecnológica para modernizar a regulação de leitos, consultas e procedimentos no SUS estadual.

- 1. 20. 35.

  Objetivo: Garantir maior eficiência na alocação de recursos assistenciais, reduzindo filas e tempos de espera.

- 1. 20. 36.

  Resultados esperados: Melhoria na gestão da regulação hospitalar e na equidade do acesso a serviços de saúde especializados.

P.2.4 Integração de Sistemas - Compra de Computadores e Desenvolvimento de Aplicativos

- 1. 20. 37.

  Descrição: Aquisição de equipamentos e desenvolvimento de aplicativos para integração dos sistemas existentes.

- 1. 20. 38.

  Objetivo: Garantir maior acessibilidade e interoperabilidade entre diferentes plataformas da SESAPI.

- 1. 20. 39.

  Resultados esperados: Maior eficiência na gestão hospitalar e otimização dos processos administrativos.

P.2.5 Construção e Equipagem de Nova Escola de Saúde Pública

- 1. 20. 40.

  Descrição: Construção de um centro educacional voltado à capacitação contínua dos profissionais de saúde do estado.

- 1. 20. 41.

  Objetivo: Qualificar os trabalhadores da saúde, promovendo formação continuada e aprimoramento das práticas assistenciais.

- 1. 20. 42.

  Resultados esperados: Maior número de profissionais capacitados e melhoria na qualidade dos serviços prestados.

P.2.6 Implantação de Protocolos de Classificação de Riscos em Urgência e Emergência

- 1. 20. 43.

  Descrição: Implementação de protocolos baseados na Política Nacional de Humanização, garantindo triagem eficiente e priorização adequada dos casos urgentes.

- 1. 20. 44.

  Objetivo: Reduzir o tempo de espera nas emergências hospitalares e organizar melhor os fluxos de atendimento.

- 1. 20. 45.

  Resultados esperados: Atendimento mais ágil e redução de riscos associados ao atendimento tardio.

P.2.7 Capacitação e Educação Permanente em Gestão da Saúde

- 1. 20. 46.

  Descrição: Desenvolvimento de cursos e treinamentos para aprimorar a gestão hospitalar e dos serviços de saúde pública.

- 1. 20. 47.

  Objetivo: Capacitar profissionais para aprimorar a eficiência da gestão da saúde estadual.

- 1. 20. 48.

  Resultados esperados: Profissionais mais qualificados e melhor gestão dos recursos da saúde.

P.2.8 Certificação por Qualidade de Hospitais Regionais (Sede de Macrorregionais)

- 1. 20. 49.

  Descrição: Implementação de padrões de qualidade em 4 hospitais estratégicos do estado.

- 1. 20. 50.

  Objetivo: Melhorar a segurança e a eficiência dos serviços hospitalares.

- 1. 20. 51.

  Resultados esperados: Hospitais mais qualificados e melhoria da satisfação dos usuários.

P.2.9 Apoio à Certificação de Qualidade Hospitalar

- 1. 20. 52.

  Descrição: Fomento a programas de certificação de qualidade para unidades hospitalares do estado.

- 1. 20. 53.

  Objetivo: Elevar os padrões de atendimento e segurança nas unidades hospitalares.

- 1. 20. 54.

  Resultados esperados: Maior eficiência operacional e aumento da confiança da população na rede pública de saúde.

P.2.10 Implementação de Linhas de Cuidado para Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) e Materno-Infantil

- 1. 20. 55.

  Descrição: Desenvolvimento e aplicação de protocolos específicos para doenças crônicas e saúde materno-infantil.

- 1. 20. 56.

  Objetivo: Melhorar a prevenção e o acompanhamento de pacientes com condições crônicas e gestantes.

- 1. 20. 57.

  Resultados esperados: Redução da morbimortalidade materno-infantil e melhor controle de doenças crônicas.

1. 20. 58. **Informações do 3° componente:**
Nome: FORTALECIMENTO DE MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS
Valor estimado em Real (BRL): 56.964.180,00

Descrição:
O Componente 3 tem como objetivo fortalecer a atenção especializada para grupos populacionais em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência e usuários com necessidades em saúde mental. O foco desse componente é garantir um modelo de assistência integrado e qualificado, promovendo a ampliação do acesso a

serviços especializados e a melhoria da capacidade assistencial nas redes de atenção à saúde.

As ações previstas incluem a construção e equipagem de centros de referência para atendimento integral a esses grupos, visando à descentralização dos serviços e ao fortalecimento da longitudinalidade do cuidado. Além disso, esse componente contribuirá para a consolidação do modelo assistencial em redes integradas, garantindo que os hospitais desempenhem um papel estratégico na continuidade do atendimento.

Objetivo do Componente: Ampliar e qualificar a assistência especializada para pessoas idosas, pessoas com deficiência e usuários com necessidades em saúde mental, por meio da construção de centros de referência que possibilitem um atendimento multiprofissional e integrado, fortalecendo a articulação entre diferentes níveis de atenção e garantindo maior equidade no acesso aos serviços de saúde.

Relação com a Solução Proposta: Este componente responde à necessidade de expansão da atenção especializada para grupos vulneráveis, reduzindo a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência e fortalecendo o atendimento contínuo e humanizado. A implantação dos centros de referência contribuirá para a oferta de serviços especializados em todas as macrorregiões do estado, garantindo acompanhamento adequado e articulado com a rede de atenção primária e hospitalar.

Relação com os Resultados Esperados: A implementação do Componente 3 permitirá a ampliação da oferta de serviços especializados para idosos, PCDs e usuários de saúde mental, garantindo maior cobertura e qualidade assistencial. Com isso, espera-se reduzir a necessidade de deslocamentos de longa distância para acesso a esses serviços, melhorar a coordenação do cuidado e fortalecer ações de promoção da saúde e prevenção de agravos.

Alinhamento com o PPA 2024-2027:

- 1. 20. 59.

  Objetivo Estratégico nº 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 20. 60.

  Objetivo Estratégico nº 111: Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação,saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 3 - Fortalecimento de Modelos de Atenção e Cuidados tem como objetivo expandir e qualificar os serviços especializados destinados a grupos em situação de vulnerabilidade, como idosos, pessoas com deficiência intelectual e usuários com necessidades em saúde mental. O fortalecimento da assistência multiprofissional e integrada garantirá maior equidade no acesso à saúde, promovendo um modelo assistencial centrado no cuidado contínuo e humanizado.

Os produtos abaixo detalham as ações estratégicas planejadas dentro do Componente C.3.

P.3.1 Construção de Centros de Reabilitação e Centros de Referência para Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência Intelectual e para Apoio à Saúde Mental

- 1. 20. 61.

  Descrição: Construção e equipagem de 12 unidades especializadas, sendo 3 para cada tipo, para atendimento integral de idosos, pessoas com deficiência intelectual e usuários de serviços de saúde mental, promovendo assistência multiprofissional, reabilitação e acompanhamento contínuo.

- 1. 20. 62.

  Objetivo: Ampliar a capacidade assistencial do sistema de saúde, descentralizando e fortalecendo o atendimento especializado para esses grupos populacionais.

- 1. 20. 63. Resultados esperados:
  - 1. 20. 64.

    Maior acesso aos serviços de reabilitação e suporte multiprofissional.

  - 1. 20. 65.

Redução da sobrecarga de atendimento em unidades hospitalares gerais.

- 1. 20. 66.

  Promoção da inclusão social e da autonomia dos usuários atendidos.

- 1. 20. 67.

  Melhoria na qualidade de vida das populações atendidas.

O Componente 3 contribui diretamente para a consolidação de um modelo de atenção que prioriza a equidade no acesso à saúde e o atendimento humanizado a populações vulneráveis. A implementação desse componente promoverá um impacto positivo na descentralização dos serviços especializados, fortalecendo o cuidado integral e reduzindo barreiras de acesso para esses grupos.

1. 20. 68. **Informações do 4° componente:**
Nome: GESTÃO DO PROGRAMA
Valor estimado em Real (BRL): 36.036.000,00

Descrição:
O Componente 4 tem como objetivo estruturar e fortalecer a governança do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI), garantindo sua gestão eficiente e monitoramento contínuo. A implementação desse componente envolve a criação de mecanismos de planejamento, supervisão e avaliação de impacto das ações executadas, assegurando transparência e efetividade na aplicação dos recursos.

A administração e avaliação do programa permitirão a adoção de boas práticas na execução das iniciativas, viabilizando o acompanhamento dos resultados e a implementação de ajustes necessários para otimizar o desempenho do programa. Esse componente também prevê a contratação de equipe técnica qualificada para apoiar a gestão do PROSUS PI, além da realização de estudos de impacto e monitoramento das ações previstas.

Objetivo do Componente: Garantir a estruturação, o gerenciamento e o acompanhamento contínuo do PROSUS PI, promovendo maior controle e eficiência na execução do programa e assegurando que os investimentos realizados resultem em melhorias efetivas na rede de saúde estadual.

Relação com a Solução Proposta: A implementação desse componente responde à necessidade de fortalecimento da gestão do programa, garantindo um acompanhamento rigoroso das ações e possibilitando a correção de eventuais desvios na execução. O desenvolvimento de estratégias de monitoramento e avaliação permite uma gestão mais transparente e eficiente, promovendo a utilização otimizada dos recursos disponíveis.

Relação com os Resultados Esperados: A estruturação adequada da administração e avaliação do programa possibilitará uma implementação mais eficaz das ações previstas no PROSUS PI, permitindo a mensuração dos impactos alcançados e a melhoria contínua das políticas públicas de saúde. Entre os principais resultados esperados, destacam-se:

- 1. 20. 69.

  Maior eficiência na gestão e execução do programa.

- 1. 20. 70.

  Monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho.

- 1. 20. 71.

  Melhor transparência na aplicação dos recursos.

- 1. 20. 72.

  Identificação de boas práticas e oportunidades de melhoria.

Alinhamento com o PPA 2024-2027:

- 1. 20. 73.

  Objetivo Estratégico nº 102: Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do SUS.

- 1. 20. 74.

  Objetivo Estratégico nº 303: Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população.

- 1. 20. 75.

  Objetivo Estratégico nº 306: Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos.

Descrição de subcomponentes e produtos:
O Componente 4 tem como objetivo estruturar e fortalecer a governança do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI), garantindo eficiência na gestão, monitoramento contínuo e transparência na execução das ações. A implementação desse componente assegura a criação de mecanismos de planejamento, supervisão e avaliação de impacto, otimizando o uso dos recursos e promovendo melhorias contínuas nas estratégias do programa.

Os produtos abaixo detalham as intervenções estratégicas planejadas dentro do Componente C.4.

P.4.1 Estruturação da Gestão - Apoio ao Gerenciamento (Contratação de Unidade de Gestão do Projeto)

- 1. 20. 76.

  Descrição: Implementação de uma estrutura de governança voltada ao gerenciamento eficaz do PROSUS PI, incluindo a contratação de uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP) para apoiar a supervisão e coordenação das atividades do programa.

- 1. 20. 77.

  Objetivo: Garantir uma gestão eficiente e integrada, assegurando o cumprimento das metas, a aplicação correta dos recursos e o acompanhamento dos impactos gerados pelo programa.

- 1. 20. 78.

  Resultados esperados:

  - 1. 20. 79.

    Maior eficiência na execução do programa;

  - 1. 20. 80.

    Melhor coordenação das atividades administrativas e operacionais;

  - 1. 20. 81.

    Monitoramento contínuo dos indicadores de desempenho e cumprimento das metas estabelecidas.

P.4.2 Contratação de Estudos de Avaliação de Impacto e Monitoramento

- 1. 20. 82.

  Descrição: Realização de estudos técnicos e avaliações periódicas para medir o impacto das ações implementadas pelo PROSUS PI, além do desenvolvimento de estratégias para o monitoramento dos indicadores de saúde e desempenho do programa.

- 1. 20. 83.

  Objetivo: Fornecer insumos técnicos e evidências para o aperfeiçoamento contínuo do programa, garantindo que os investimentos realizados resultem em melhorias concretas na rede de saúde do estado.

- 1. 20. 84.

  Resultados esperados:

- 1. 20. 85.

  Maior transparência e controle sobre a execução do programa;

- 1. 20. 86.

  Identificação de boas práticas e ajustes estratégicos para maximizar os impactos das ações;

- 1. 20. 87.

  Melhor embasamento técnico para formulação de futuras políticas públicas de saúde.

P.4.3 Supervisão Técnica, Ambiental e Social

- 1. 20. 88.

  Descrição: Este produto visa assegurar a fiscalização rigorosa das obras e intervenções implementadas no projeto, garantindo que todas as ações sejam executadas conforme os projetos aprovados e em conformidade com as normativas técnicas, ambientais e sociais vigentes.

- 1. 20. 89.

  Informações Objetivas:

  - 1. 20. 90.

    Realização de monitoramento contínuo das obras e intervenções;

  - 1. 20. 91.

    Implementação de medidas que assegurem a conformidade ambiental, incluindo a verificação de práticas sustentáveis e a adoção de métodos construtivos resilientes, como a certificação LEED para os equipamentos e instalações.

- 1. 20. 92.

  Objetivo: Garantir que a execução física do projeto ocorra de forma segura, transparente, sustentável e de acordo com os padrões técnicos exigidos.

- 1. 20. 93.

  Resultados esperados:

  - 1. 20. 94.

    Maior qualidade e segurança na execução das obras;

  - 1. 20. 95.

    Conformidade ambiental e social com os padrões nacionais e internacionais;

  - 1. 20. 96.

    Redução de riscos operacionais e fortalecimento da sustentabilidade das intervenções.

Os produtos do Componente C.4 são fundamentais para garantir uma gestão eficaz e uma avaliação criteriosa dos impactos do PROSUS PI. A implementação desse componente reforça a governança do programa, assegurando maior eficiência na execução das ações e promovendo uma cultura de monitoramento e melhoria contínua na gestão da saúde pública do Estado do Piauí.

1. 21. **Beneficiários**

O Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) tem como beneficiários diretos e indiretos a população do estado, com ênfase nos grupos que apresentam maior vulnerabilidade e dificuldades de acesso a

serviços de saúde de qualidade. A implementação do programa visa reduzir as desigualdades regionais e ampliar a capacidade assistencial da rede pública de saúde, promovendo um atendimento mais eficiente e equitativo.

População Prioritariamente Atendida

1. 21. 1.

População Geral do Estado do Piauí: O programa impactará toda a população estadual, que ultrapassa 3,2 milhões de habitantes (Fonte: IBGE, 2022), promovendo melhorias estruturais e tecnológicas no sistema público de saúde, garantindo maior resolutividade nos atendimentos e serviços.

1. 21. 2.

Grupos em Situação de Vulnerabilidade:

- 1. 21. 3.

  Gestantes e Neonatos: Estima-se que aproximadamente 72.000 gestantes por ano sejam beneficiadas diretamente pelas melhorias na Rede Materno-Infantil, com impactos positivos também para cerca de 65.000 recém-nascidos anualmente (Fonte: SINASC/DATASUS, 2022).

- 1. 21. 4.

  Idosos: A população idosa do Piauí, que atualmente representa 12,8% da população total (cerca de 410.000 pessoas), será diretamente beneficiada pelo fortalecimento da rede de atendimento especializado (Fonte: IBGE - PNAD Contínua, 2022).

- 1. 21. 5.

  Pessoas com Deficiência: Segundo dados do IBGE, cerca de 17,5% da população piauiense (aproximadamente 560.000 pessoas) possuem algum tipo de deficiência e serão contempladas com os centros de reabilitação e serviços especializados (Fonte: IBGE - Censo Demográfico, 2010).

- 1. 21. 6.

  Usuários de Saúde Mental: Considerando que 10% da população pode necessitar de atendimento contínuo em saúde mental, estima-se que cerca de 320.000 pessoas possam se beneficiar diretamente da ampliação dos serviços (Fonte: OMS, Relatório Mundial de Saúde Mental, 2022).

1. 21. 7.

Pacientes em Regiões com Deficiência de Infraestrutura Hospitalar:

- 1. 21. 8.

  A modernização e ampliação da rede hospitalar beneficiarão diretamente cerca de 1,5 milhão de habitantes das regiões com menor cobertura de serviços de saúde especializada (Fonte: Ministério da Saúde - PRI, 2023).

- 1. 21. 9.

  A descentralização dos serviços reduzirá o deslocamento de pacientes para a capital, garantindo acesso equitativo a cuidados especializados nas 12 macrorregiões de saúde.

1. 21. 10.

Profissionais de Saúde:

- 1. 21. 11.

  O programa contemplará ações de capacitação e formação contínua para cerca de 30.000 profissionais da saúde, fortalecendo a gestão hospitalar e a qualidade assistencial (Fonte: CNES/DATASUS, 2023).

- 1. 21. 12.

A melhoria da infraestrutura dos hospitais e a modernização dos equipamentos possibilitarão melhores condições de trabalho para mais de 15.000 médicos, enfermeiros e demais profissionais da rede pública estadual (Fonte: CNES/DATASUS, 2023).

Carências a serem Endereçadas

- 1. 21. 13.

  Déficit de infraestrutura hospitalar e serviços especializados: O programa atuará na expansão e modernização da rede de hospitais, maternidades, policlínicas e centrais de exames.

- 1. 21. 14.

  Baixa cobertura de atenção especializada em saúde mental e reabilitação: A construção de centros especializados garantirá atendimento integral e contínuo a esses grupos.

- 1. 21. 15.

  Dificuldade no acesso a exames e procedimentos especializados: O aumento da oferta de consultas e exames reduzirá filas e tempos de espera.

- 1. 21. 16.

  Falta de integração dos serviços de saúde: A digitalização e a melhoria da gestão hospitalar fortalecerão a regulação e a eficiência do sistema público de saúde.

A implementação do PROSUS PI contribuirá significativamente para a melhoria das condições de saúde da população piauiense, promovendo maior equidade e acesso a serviços essenciais, reduzindo desigualdades e fortalecendo a rede pública de atenção à saúde.

1. 22. **Anexos**

Sem anexos.

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Este projeto é exclusivamente destinado ao atendimento da prioridade “IV – Saúde: Atenção Primária e Especializada”, conforme estabelecido no art. 15, § 3º, IV, da Resolução Normativa Nº 1, de 22 de novembro de 2024. No âmbito do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, as intervenções propostas se alinham diretamente a quatro Objetivos Estratégicos, promovendo avanços estruturais e sustentáveis na área de saúde.

2. 1. 1.

Objetivo Estratégico 102

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: A (5 pontos)

Justificativa:
O PROSUS PI está diretamente alinhado a esse objetivo, com foco na ampliação do acesso, qualificação da rede especializada e modernização da gestão em saúde, em todo o território do Piauí.

Seus objetivos específicos reforçam esse alinhamento, com ações como:

- 2. 1. 2.

  a) Reestruturar a rede hospitalar com obras e aquisições;

- 2. 1. 3.

  c) Regionalizar o atendimento a populações vulneráveis;

- 2. 1. 4.

  e) Digitalizar processos e qualificar a gestão estadual de saúde.

O programa apresenta indicadores e metas SMART, como:

- 2. 1. 5.

  Redução da razão de mortalidade materna (88,25 ? 74,05);

- 2. 1. 6.

  Aumento de cirurgias eletivas (24.538 ? 43.576);

- 2. 1. 7.

  Prontuário eletrônico em 29 unidades (meta 2030);

- 2. 1. 8.

  Ampliação de consultas em telemedicina.

Os impactos são estruturantes, com alto potencial de replicação em outros estados, ao combinar intervenções físicas, digitais e institucionais. A abrangência estadual e a cobertura de 12 regiões de saúde garantem capilaridade e equidade.

As soluções propostas são efetivas, inovadoras e viáveis, com foco na resolutividade e continuidade do cuidado.

2. Objetivo Estratégico 303

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: B (3 pontos)

Justificativa:
O PROSUS PI contribui diretamente para o avanço da transformação digital da saúde pública no Estado do Piauí, ao

modernizar a gestão, integrar sistemas e ampliar o uso de tecnologias no SUS estadual.

Entre as principais ações destacam-se:

- 2. 1. 9.

  Implantação de prontuário eletrônico em 29 unidades de média e alta complexidade, garantindo rastreabilidade e continuidade do cuidado (P.2.4);

- 2. 1. 10.

  Expansão do Programa Piauí Saúde Digital, com aumento de consultas por telemedicina (P.2.1);

- 2. 1. 11.

  Modernização das centrais de regulação e logística, com controle informatizado de leitos e insumos (P.2.2 e P.2.3);

- 2. 1. 12.

  Integração de sistemas da SESAPI, com aquisição de equipamentos e desenvolvimento de aplicativos.

- 2. 1. 13.

  Essas ações estão ligadas ao objetivo específico e) do programa, que prevê a adoção de tecnologias, regulação digital e capacitação em gestão moderna.

O programa apresenta metas mensuráveis e viáveis, como o aumento de 7 para 29 unidades com prontuário eletrônico até 2030 e o crescimento das teleconsultas para quase 79 mil no mesmo período.

3. Objetivo Estratégico 111

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: C (2 pontos)

Embora o foco principal do PROSUS PI seja o fortalecimento da rede de saúde especializada, o programa contribui de forma complementar para o avanço do Objetivo Estratégico 111 ao ampliar e modernizar a infraestrutura urbana de saúde, com impacto direto na qualidade de vida e na inclusão social.

As ações previstas contribuem para o reequilíbrio territorial da oferta de serviços públicos, sobretudo em regiões com vazios assistenciais, por meio de:

- 2. 1. 14.

  Reforma e requalificação de hospitais com melhorias estruturais voltadas à eficiência energética e acessibilidade (P.1.1 e P.1.2);

- 2. 1. 15.

  Implantação de policlínicas e centros de referência, descentralizando os serviços especializados e reduzindo deslocamentos (P.1.5 e P.3.1);

- 2. 1. 16.

  Atendimento a grupos vulneráveis, como idosos, PCDs e pessoas com transtornos mentais, com unidades adaptadas às necessidades dessa população (P.3.1);

- 2. 1. 17.

  Adoção de práticas sustentáveis nas obras, com monitoramento técnico, ambiental e social (P.4.3).

- 2. 1. 18.

  O objetivo específico b) está alinhado a esse eixo, reforçando a qualificação dos equipamentos sociais em áreas urbanas e regionais.

4. Objetivo Estratégico 202

Nível de adequação e de impacto do projeto à área estratégica: C (2 pontos)

Justificativa:
Embora o PROSUS PI não tenha como foco central a agenda climática, contribui de forma transversal para o fortalecimento da resiliência da infraestrutura de saúde e para a capacidade de resposta a emergências sanitárias e ambientais.

O programa prevê ações alinhadas a esse objetivo, como:

- 2. 1. 19.

  Obras com padrões sustentáveis, com possibilidade de certificação LEED, eficiência energética e uso racional de recursos (P.1.1 e supervisão – P.4.3);

- 2. 1. 20.

  Ampliação e modernização da rede de urgência e emergência (P.1.4), facilitando respostas rápidas a crises de saúde pública;

- 2. 1. 21.

  Fortalecimento da logística com novas centrais de armazenamento e controle de insumos (P.2.2);
  Implantação de sistemas digitais integrados, melhorando a regulação, monitoramento e gestão de riscos (P.2.3 e P.2.4).

- 2. 1. 22.

  O objetivo específico f) está diretamente relacionado a essa agenda.

2. 2. **Anexos**

Sem anexos.

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

A implementação do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) envolve a participação de diversas instituições, cada uma desempenhando um papel fundamental para garantir a execução eficiente e coordenada das ações previstas. A governança do programa será baseada em um modelo de gestão integrada, com responsabilidades claramente definidas para cada instituição envolvida.

Instituições Envolvidas e seus Papéis

3. 1. 1. 1.

Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI)

- 3. 1. 1. 2.

  Órgão executor do programa, responsável pela coordenação geral, planejamento estratégico, monitoramento da execução física e financeira, além da supervisão das ações de fortalecimento da rede de saúde estadual.

- 3. 1. 1. 3.

  Responsável pela articulação interinstitucional e integração das ações com as políticas estaduais de saúde.

3. 1. 1. 4.

Governo do Estado do Piauí

- 3. 1. 1. 5.

  Instituição proponente do financiamento e garantidor da execução do programa.

- 3. 1. 1. 6.

  Responsável por fornecer suporte institucional e normativo para a implementação do programa.

3. 1. 1. 7.

Unidade de Gestão do Projeto (UGP)

- 3. 1. 1. 8.

  Criada para apoiar a execução do PROSUS PI, a UGP será responsável pelo gerenciamento técnico e administrativo das ações, acompanhamento dos cronogramas e indicadores, bem como pela prestação de contas e elaboração de relatórios periódicos.

- 3. 1. 1. 9.

  Garantirá a articulação entre as diferentes instituições envolvidas, promovendo maior eficiência e transparência na execução do programa.

3. 1. 1. 10.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)

- 3. 1. 1. 11.

  Instituição responsável pelo financiamento das ações do programa.

- 3. 1. 1. 12.

  Acompanha e avalia a implementação das metas e compromissos assumidos no contrato de financiamento.

3. 1. 1. 13.

Ministério da Saúde (MS)

- 3. 1. 1. 14.

  Responsável pela normatização e apoio técnico na implementação das ações do programa.

- 3. 1. 1. 15.

  Acompanha e fiscaliza a execução das políticas e diretrizes nacionais de saúde vinculadas ao programa.

3. 1. 1. 16.

Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) e Controladoria Geral do Estado (CGE-PI)

- 3. 1. 1. 17.

  Realizam auditorias e fiscalizam a aplicação dos recursos do programa, garantindo transparência e conformidade com a legislação vigente.

3. 1. 1. 18.

Prefeituras Municipais e Redes Regionais de Saúde

- 3. 1. 1. 19.

  Parceiras na implementação das ações, garantindo que os serviços e estruturas modernizadas pelo programa sejam devidamente integrados às redes locais de saúde.

3. 1. 2. **Orgãos Executores:**
Órgão principal: Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI)
Órgãos parceiros:

3. 1. 3. **Estrutura Operacional:**

A execução do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) será conduzida por instituições com ampla capacidade técnica e administrativa, garantindo a implementação eficiente das ações propostas.

Capacidade Institucional do Órgão Executor

A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), como órgão executor do programa, possui experiência consolidada na gestão de projetos voltados para a melhoria da infraestrutura e serviços de saúde pública. A SESAPI conta com:

- 3. 1. 4.

  Equipe técnica qualificada composta por 28 profissionais de áreas estratégicas para execução do Programa.

- 3. 1. 5.

  Experiência na execução de projetos financiados por organismos internacionais, com histórico de parcerias com instituições como o Ministério da Saúde e o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

A execução das ações contará com o suporte de uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), que atuará na coordenação e no acompanhamento técnico, operacional e financeiro das atividades do programa.

Recursos e Estruturas Disponíveis

A implementação do PROSUS PI utilizará os seguintes recursos e estruturas disponíveis:

- 3. 1. 6.

  Sistema informatizado de gestão para monitoramento do desempenho das ações e indicadores do programa.

- 3. 1. 7.

Redes regionais de saúde estruturadas para viabilizar a execução das atividades de ampliação e modernização da infraestrutura hospitalar.

- 3. 1. 8.

  Capacitação de profissionais para garantir a qualificação contínua das equipes envolvidas na gestão e execução das ações do programa.

Repasse de Recursos Entre Órgãos Participantes

O modelo de execução do PROSUS PI prevê a execução direta pela SESAPI, sem repasse de recursos para municípios ou outras entidades. No entanto, as ações serão desenvolvidas em articulação com as Prefeituras Municipais e Redes Regionais de Saúde, garantindo integração e eficiência na operacionalização do programa.

A adoção desse modelo assegura maior controle sobre a aplicação dos recursos, facilitando o monitoramento e a prestação de contas aos órgãos de controle e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

3. 1. 9. **Matriz de Responsabilidade:**

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE PROSUS PI.pdf

3. 2. **Operacionalização e Manutenção**

A implementação do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) prevê a adoção de estratégias para garantir a continuidade das ações após o término do programa, assegurando a adequada operacionalização e manutenção das infraestruturas, equipamentos e serviços implementados.

Estratégias de Continuidade e Sustentabilidade

3. 2. 1.

Planejamento Integrado da Gestão da Saúde

- 3. 2. 2.

  A SESAPI atuará na formulação de um plano estratégico de gestão, integrando os serviços expandidos às redes regionais de saúde, garantindo a eficiência na alocação de recursos e a continuidade dos atendimentos.

3. 2. 3.

Capacitação e Formação Contínua de Profissionais

- 3. 2. 4.

  Será implementado um programa permanente de capacitação para os profissionais de saúde, garantindo que as equipes estejam preparadas para operar os novos serviços, equipamentos e unidades de saúde modernizadas.

3. 2. 5.

Modelos de Gestão e Regulação dos Serviços

- 3. 2. 6.

  A modernização da gestão hospitalar incluirá o fortalecimento dos sistemas de regulação, monitoramento de leitos e acompanhamento de indicadores de desempenho, assegurando a manutenção da qualidade dos serviços.

3. 2. 7.

Previsão de Custos de Manutenção e Fontes de Financiamento

- 3. 2. 8.

A manutenção das infraestruturas e equipamentos será custeada pelo orçamento estadual de saúde, com previsão de 10% do orçamento anual da SESAPI alocado para operação e manutenção.

- 3. 2. 9.

  Recursos complementares poderão ser captados por meio de convênios com o Ministério da Saúde e parcerias com municípios e outras instituições públicas.

- 3. 2. 10.

  O programa também prevê a utilização de estratégias de eficiência energética e otimização de recursos, reduzindo os custos operacionais e ampliando a sustentabilidade financeira.

3. 2. 11.

Monitoramento e Avaliação Contínua

- 3. 2. 12.

  A SESAPI implementará um modelo contínuo de monitoramento da qualidade dos serviços e da infraestrutura hospitalar, assegurando que as melhorias implementadas pelo programa sejam mantidas a longo prazo.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

O Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) está plenamente alinhado ao planejamento estratégico estadual vigente e contribui diretamente para o cumprimento das metas e entregas previstas no Plano Plurianual do Estado do Piauí 2024–2027, no Plano Estadual de Saúde (PES) 2024–2027, no Plano Setorial Piauí Saudável (PIS) e nos Compromissos do Governo do Estado para a Saúde 2023–2026.

No âmbito do PPA Estadual 2024–2027, o PROSUS PI está vinculado ao programa estratégico da área da saúde, contribuindo diretamente para os seguintes objetivos específicos:

- 3. 4.

  Objetivo 2: Garantir o acesso da população, de forma regionalizada, à atenção especializada de média e alta complexidade, ambulatorial e hospitalar;

- 3. 5.

  Objetivo 3: Potencializar, modernizar e qualificar a gestão da saúde, com disseminação de novos modelos de gestão, inovação tecnológica e otimização dos processos administrativos, gerenciais, financeiros, jurídicos e de fiscalização;

- 3. 6.

  Objetivo 4: Reduzir a morbimortalidade materna, fetal e infantil, garantindo a equidade no acesso e a resolutividade da atenção em todos os níveis de cuidado.

Esses objetivos estão contemplados no Anexo 1 (Plano Setorial PIS) e no Anexo 2 (Objetivos do PPA), e sua compatibilização com o PES está detalhada no Quadro 6 do PES (Anexo 3 p.96).

No âmbito do Plano Estadual de Saúde (PES) 2024–2027 (Anexo 3), o PROSUS PI contribui diretamente para:

- 3. 7.

  O Plano de Expansão da Média e Alta Complexidade (item 5.4, p. 92), por meio da ampliação da oferta de leitos e serviços especializados;

- 3. 8.

O Plano Estadual de Gestão do Trabalho e da Educação em Saúde (item 5.1, p. 90), por meio de ações de qualificação de equipes e educação permanente;

- 3. 9.

  A Diretriz 2: Garantia do acesso à atenção especializada de qualidade e com segurança;

- 3. 10.

  A Diretriz 3: Fortalecimento e modernização da gestão estadual do SUS, governança pública e controle social;

- 3. 11.

  A Diretriz 4: Redução da morbimortalidade materna, fetal e infantil.

O PROSUS PI também endereça compromissos assumidos no Plano de Governo 2023–2026, especialmente:

- 3. 12.

  GC031 – Modernizar hospitais regionais e de referência;

- 3. 13.

  GC108 – Implementar políticas de redução da morte materna, com implantação de maternidades em áreas prioritárias;

- 3. 14.

  GC111 – Fortalecer a assistência de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar.

Por fim, o programa também se articula com a Agenda 2030 das Nações Unidas, especialmente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 3, Meta 3.8: Atingir a cobertura universal de saúde, incluindo acesso a serviços essenciais de qualidade, medicamentos e vacinas seguros e eficazes.

3. 15. **Anexos**

Anexo 1 Plano Setorial Programa Piaui Saudavel PPA 2024 2027

Anexo 4 PPA PI 2024 2027 aspectos relevantes PROSUS PI

Anexo 2 PPA Estado 2024 2027

ORGANOGRAMA - ARRANJO INSTITUCIONAL

Anexo 3 Plano Estadual de Saude 2024 2027

4. **RISCOS**

4. 1. **Informações do 1° risco:**

Nome: Custeio de novas unidades de saúde
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Insuficiência de recursos financeiros para a operação e manutenção contínua das novas unidades de saúde implantadas pelo programa, incluindo hospitais, policlínicas, UPAs, centros de referência e unidades de apoio logístico e digital.

Causas Possíveis:

- 4. 2.

  Limitações orçamentárias do Estado para incorporação de novos custos permanentes ao sistema de saúde.

- 4. 3.

  Crescimento da rede física sem o planejamento proporcional de recursos humanos, insumos e contratos de serviços.

- 4. 4.

  Redução nos repasses federais ou no orçamento estadual destinado à saúde.

- 4. 5.

  Dificuldade em assegurar a sustentabilidade financeira no longo prazo, especialmente em cenários de crise fiscal.

Efeitos Negativos Potenciais:

- 4. 6.

  Subutilização ou paralisação parcial das unidades construídas ou ampliadas.

- 4. 7.

  Sobrecarga das unidades pré-existentes por falta de redistribuição eficiente dos serviços.

- 4. 8.

  Descontinuidade de serviços ofertados à população, especialmente em regiões com maior vulnerabilidade.

- 4. 9.

  Redução na eficiência e no impacto esperado do programa, comprometendo a melhoria dos indicadores de saúde.

- 4. 10.

  Repercussões negativas na imagem institucional e na credibilidade do programa junto aos financiadores e sociedade.

Prevenção e Mitigação:
Para prevenir ou mitigar os riscos associados à insuficiência de recursos para a operação e manutenção das novas unidades de saúde implantadas pelo programa, serão adotadas as seguintes ações:

1. Planejamento financeiro integrado e escalonado

- 4. 11.

  Elaboração de um plano de custeio detalhado, contemplando a expansão da rede física e os custos recorrentes com pessoal, insumos, manutenção predial e contratos de serviços.

- 4. 12.

  O plano será escalonado de acordo com a entrega progressiva das unidades, permitindo melhor adequação ao orçamento público anual.

- 4. 13.

  Responsável: SESAPI – Diretoria de Planejamento e Orçamento

2. Pactuação interinstitucional com o Governo Estadual e articulação com o Ministério da Saúde

- 4. 14.

  Inclusão antecipada das novas unidades no planejamento plurianual do Estado e nos sistemas de financiamento do SUS (FAEC, MAC, incentivos específicos).

- 4. 15.

  Busca ativa por habilitação federal das unidades elegíveis e captação de incentivos da atenção especializada.

- 4. 16.

  Responsáveis: SESAPI e Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí (SEPLAN)

3. Dimensionamento adequado da rede e otimização de recursos

- 4. 17.

  As novas unidades serão projetadas com base em critérios de eficiência, regionalização e demandas populacionais reais, evitando expansão desproporcional.

- 4. 18.

  Será priorizada a integração com a Atenção Primária e a complementaridade com unidades pré-existentes.

- 4. 19.

  Responsável: SESAPI – Superintendência de Organização da Rede de Atenção à Saúde

4. Capacitação e implantação de modelos de gestão eficientes

- 4. 20.

  Implantação de protocolos de governança, sistemas informatizados de gestão de custos e capacitação contínua dos gestores locais para garantir eficiência operacional.

- 4. 21.

  Responsáveis: SESAPI – UGP do PROSUS PI e Escola de Saúde Pública (P.2.5 e P.2.7)

5. Previsão orçamentária e reserva técnica no programa

- 4. 22.

Durante a execução do programa, será prevista margem técnica no orçamento para absorção de custos iniciais de entrada em operação das unidades.

- 4. 23.

  Responsável: SESAPI – Unidade de Gestão do Projeto (UGP)

Essas medidas visam garantir que a expansão da rede de saúde ocorra com responsabilidade fiscal, sustentabilidade operacional e continuidade dos serviços à população, assegurando a plena efetividade dos investimentos realizados no âmbito do PROSUS PI.

4. 24. **Informações do 2° risco:**
Nome: Atraso nas realização de licitações e das obras
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de atrasos significativos na condução dos processos licitatórios e na execução das obras e aquisições previstas no âmbito do programa, comprometendo o cronograma físico-financeiro, os resultados esperados e a credibilidade da gestão.

Causas Possíveis:

- 4. 25.

  Morosidade nos trâmites administrativos e burocráticos para abertura e julgamento das licitações.

- 4. 26.

  Fragilidade na elaboração dos projetos básicos e executivos, exigindo revisões técnicas e republicações.

- 4. 27.

  Recursos administrativos e jurídicos interpostos por participantes das licitações, paralisando processos.

- 4. 28.

  Capacidade limitada de empresas executoras contratadas, gerando interrupções ou baixo desempenho físico das obras.

- 4. 29.

  Dificuldades na articulação entre os diversos níveis e setores da administração pública estadual.

- 4. 30.

  Oscilações de mercado que afetam a precificação e a competitividade dos certames.

Efeitos Negativos Potenciais:

- 4. 31.

  Atraso na entrega das unidades de saúde, impactando diretamente os prazos de implementação dos serviços.

- 4. 32.

  Aumento dos custos do projeto, decorrente da necessidade de aditivos contratuais ou reequilíbrios financeiros.

- 4. 33.

  Redução da eficácia do programa em atender aos objetivos e metas pactuadas com o banco financiador (BID).

- 4. 34.

  Perda de credibilidade institucional perante os órgãos de controle, financiadores internacionais e a população beneficiária.

- 4. 35.

  Possível comprometimento da execução orçamentária anual e necessidade de reprogramação financeira.

Prevenção e Mitigação:
Para prevenir ou mitigar os riscos associados ao atraso nas licitações e na execução das obras previstas no PROSUS PI, serão adotadas as seguintes estratégias:

1. Planejamento prévio detalhado e qualificação dos projetos executivos

- 4. 36.

  Elaboração e revisão criteriosa dos projetos básicos e executivos antes da abertura dos certames, com foco na qualidade técnica e na viabilidade operacional.

- 4. 37.

  Inclusão de memoriais descritivos, cronogramas físicos e orçamentos de referência compatíveis com os preços de mercado.

- 4. 38.

  Responsáveis: SESAPI – Diretoria de Engenharia e UGP do PROSUS PI

2. Fortalecimento da equipe técnica de licitações e contratações

- 4. 39.

  Alocação de equipe especializada para condução dos processos licitatórios, com treinamento contínuo em legislação atualizada, planejamento de compras públicas e gestão contratual.

- 4. 40.

  Apoio da Procuradoria Geral do Estado (PGE-PI) e Controladoria Geral do Estado (CGE-PI) nos processos sensíveis.

- 4. 41.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI, Comissão Permanente de Licitação (CPL) da SESAPI

3. Adoção de cronograma realista e pactuado intersetorialmente

- 4. 42.

  Elaboração de um cronograma físico-financeiro realista, com margens de segurança para contratempos e articulado com as áreas técnicas, administrativas e jurídicas envolvidas no programa.

- 4. 43.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Diretoria de Planejamento/SESAPI

4. Mecanismos de monitoramento contínuo e alerta prévio

- 4. 44.

  Utilização de ferramentas de gestão informatizada para o acompanhamento do andamento dos processos licitatórios e das obras, com painéis de controle e indicadores de desempenho.

- 4. 45.

  Gatilhos de alerta para antecipação de atrasos críticos, permitindo tomada de decisão tempestiva.

- 4. 46.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e empresa de apoio à supervisão do programa (P.4.3)

5. Reforço contratual para cumprimento de prazos

- 4. 47.

  Inclusão de cláusulas contratuais específicas que prevejam penalidades por descumprimento de prazos, inadimplemento de metas físicas ou abandono de obras.Realização de reuniões técnicas com as empresas contratadas para alinhamento de cronogramas e exigência de planos de recuperação quando necessário.

- 4. 48.

  Responsáveis: SESAPI – Supervisão Técnica de Obras e Jurídico

6. Estruturação de apoio técnico externo (auditoria/supervisão)

- 4. 49.

  Contratação de empresa especializada para supervisionar as obras e aquisições, com foco em conformidade técnica, ambiental e social, garantindo maior agilidade na resolução de entraves.

- 4. 50.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI (Produto P.4.3)

Estas ações permitirão maior controle sobre os riscos logísticos e operacionais do programa, garantindo o cumprimento dos prazos, a eficiência na aplicação dos recursos públicos e a entrega tempestiva dos resultados esperados pelo PROSUS PI.

4. 51. **Informações do 3° risco:**
Nome: Transição de Governo Estadual
Impacto: Alto
Probabilidade: Média

Descrição:
O risco está associado à possibilidade de descontinuidade ou enfraquecimento do apoio político e institucional ao PROSUS PI durante ou após uma eventual transição de governo estadual, especialmente em caso de mudança de gestão após eleições. A alternância de poder pode resultar em mudanças nas prioridades políticas e administrativas, afetando o ritmo, o escopo e a continuidade do programa.

Causas Possíveis:

- 4. 52.

  Mudança na liderança do Executivo Estadual e substituição de cargos estratégicos na Secretaria de Estado da Saúde (SESAPI).

- 4. 53.

Redefinição de políticas públicas e reorientação das prioridades orçamentárias da nova gestão.

- 4. 54.

  Desmobilização das equipes técnicas envolvidas no planejamento e execução do programa.

- 4. 55.

  Falta de conhecimento técnico ou alinhamento político da nova gestão com os compromissos assumidos junto ao banco financiador (BID).

Efeitos Negativos Potenciais:

- 4. 56.

  Interrupção ou atraso na execução física e financeira do programa.

- 4. 57.

  Redução da efetividade e do escopo das ações planejadas.

- 4. 58.

  Perda de credibilidade junto ao banco financiador e aos órgãos de controle.

- 4. 59.

  Risco de não cumprimento dos indicadores e metas pactuadas.

- 4. 60.

  Desarticulação institucional e perda de capacidade técnica instalada.

Prevenção e Mitigação:
Diante da possibilidade de mudanças na gestão estadual ao longo do ciclo de implementação do PROSUS PI, serão adotadas medidas preventivas e corretivas com o objetivo de garantir a continuidade institucional do programa, independentemente da alternância de governo.

1. Institucionalização do programa na estrutura da SESAPI

- 4. 61.

  O PROSUS PI será incorporado formalmente à estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), por meio de portarias e atos normativos que assegurem sua continuidade como política de Estado.

- 4. 62.

  Responsáveis: SESAPI e UGP do PROSUS PI

2. Estruturação técnica independente de cargos políticos

- 4. 63.

  A Unidade de Gestão do Projeto (UGP) contará com equipe técnica qualificada, contratada por meio de critérios técnicos e não político-partidários, com foco na permanência da capacidade operacional ao longo de diferentes gestões.

- 4. 64.

Responsável: UGP do PROSUS PI

3. Registro sistemático e publicização de resultados

- 4. 65.

  Implementação de mecanismos de monitoramento contínuo com produção de relatórios públicos, boletins de acompanhamento e painéis de resultados, facilitando o controle social e a valorização pública do programa.

- 4. 66.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Assessoria de Comunicação da SESAPI

4. Diálogo com o banco financiador e com órgãos de controle

- 4. 67.

  Estabelecimento de canais de comunicação contínuos com o BID, a CGE e o TCE-PI, reforçando o compromisso institucional assumido pelo Estado, independentemente de mudanças de governo.

- 4. 68.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e SEPLAN

5. Inclusão do programa no Plano Plurianual e em outros instrumentos oficiais de planejamento

- 4. 69.

  Inserção do PROSUS PI no Plano Plurianual (PPA) e no Plano Estadual de Saúde (PES) 2024–2027 como iniciativa prioritária, vinculando seus objetivos às metas estratégicas de médio prazo do Estado.

- 4. 70.

  Responsáveis: SESAPI – Diretoria de Planejamento e SEPLAN

6. Sensibilização de novas gestões sobre a importância do programa

- 4. 71.

  Em caso de transição de governo, promover articulações institucionais com a equipe de transição e a nova gestão para apresentação dos avanços do programa, evidências técnicas e benefícios à população.

- 4. 72.

  Responsáveis: SESAPI, UGP do PROSUS PI e Casa Civil

Estas medidas visam garantir que o PROSUS PI se mantenha como uma política pública prioritária, assegurando estabilidade institucional, continuidade das ações e comprometimento com os resultados pactuados, mesmo diante de possíveis alterações no cenário político estadual.

4. 73. **Informações do 4° risco:**
Nome: Riscos nas contratações
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Risco de dificuldades na seleção e contratação de fornecedores e prestadores de serviços qualificados, o que pode comprometer a qualidade, o prazo e a efetividade da execução das obras, aquisições e demais componentes do PROSUS PI.

Causas Possíveis:

- 4. 74.

  Baixa atratividade dos certames para fornecedores com maior capacidade técnica e operacional, especialmente em regiões mais distantes ou com infraestrutura limitada.

- 4. 75.

  Ausência ou escassez de empresas com experiência em projetos complexos ou com exigências específicas previstas em contratos internacionais.

- 4. 76.

  Documentação inadequada ou inconsistências nas propostas apresentadas pelas empresas participantes.

- 4. 77.

  Alta rotatividade de fornecedores e desistência durante o processo licitatório ou na fase inicial de execução contratual.

- 4. 78.

  Dificuldades na adaptação de empresas locais aos padrões técnicos, ambientais, sociais e administrativos exigidos por financiadores internacionais (como o BID).

Efeitos Negativos Potenciais:

- 4. 79.

  Fracasso de licitações e necessidade de republicação, gerando atrasos no cronograma do programa.

- 4. 80.

  Seleção de fornecedores com baixa capacidade de entrega, resultando em obras mal executadas, ineficiência técnica ou paralisações.

- 4. 81.

  Aumento de custos com aditivos contratuais para correções ou substituições.

- 4. 82.

  Comprometimento da qualidade das entregas e dos serviços prestados à população.

- 4. 83.

  Prejuízo à imagem do programa junto à sociedade, aos órgãos de controle e ao banco financiador.

Prevenção e Mitigação:
Diante do risco de dificuldades na seleção de fornecedores qualificados para a execução das ações previstas no PROSUS PI, serão adotadas medidas preventivas e corretivas com o objetivo de assegurar contratações eficientes, transparentes e aderentes aos padrões de qualidade e conformidade exigidos pelo financiamento internacional.

1. Elaboração de termos de referência e projetos básicos qualificados

- 4. 84.

  Preparação técnica minuciosa dos termos de referência, projetos executivos e especificações técnicas, com linguagem clara, critérios objetivos de avaliação e exigências proporcionais à complexidade da contratação.

- 4. 85.

  Adoção de modelos padronizados validados em outros programas com recursos internacionais.

- 4. 86.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Diretorias Técnicas da SESAPI

2. Divulgação antecipada dos editais e articulação com o mercado

- 4. 87.

  Promoção de diálogos prévios com potenciais fornecedores, empresas do setor e conselhos profissionais, com vistas a esclarecer os objetivos do programa e os padrões exigidos.

- 4. 88.

  Utilização de avisos públicos e estratégias de comunicação para ampliar a concorrência e a participação de empresas qualificadas.

- 4. 89.

  Responsáveis: SESAPI – Comissão Permanente de Licitação (CPL), UGP e Assessoria de Comunicação

3. Capacitação da equipe de licitações e controle de qualidade

- 4. 90.

  Treinamento contínuo das equipes da CPL e das áreas técnicas para análise de propostas, julgamento de habilitação e gestão contratual com base na legislação vigente e nos procedimentos do BID.

- 4. 91.

  Acompanhamento e supervisão técnica rigorosa dos fornecedores durante a execução contratual.

- 4. 92.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Secretaria de Administração do Estado (SEAD)

4. Cláusulas contratuais que reforcem o compromisso com a entrega

- 4. 93.

  Inclusão de cláusulas de desempenho, prazos, penalidades e garantias contratuais que assegurem a execução conforme o escopo técnico e os cronogramas pactuados.

- 4. 94.

  Definição de critérios de experiência mínima e capacidade operacional compatíveis com as exigências do projeto.

- 4. 95.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Procuradoria Geral do Estado (PGE-PI)

5. Apoio técnico especializado às contratações complexas

- 4. 96.

Previsão de consultoria técnica e jurídica especializada para a estruturação de contratações de maior complexidade, garantindo alinhamento às normas do BID e mitigação de riscos legais ou operacionais.

- 4. 97.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Consultores Contratados

Essas ações visam garantir que as contratações no âmbito do PROSUS PI sejam conduzidas com excelência técnica, integridade, transparência e aderência aos marcos regulatórios, assegurando o êxito na execução das obras e serviços e o alcance dos objetivos do programa.

4. 98. **Informações do 5° risco:**
Nome: Riscos legais
Impacto: Médio
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Possibilidade de ocorrência de impedimentos legais que dificultem ou inviabilizem a execução de etapas do programa, especialmente no que diz respeito à tramitação de processos administrativos, obtenção de licenças, regularizações fundiárias ou cumprimento de exigências ambientais, sanitárias e urbanísticas. Esse risco também inclui a judicialização de processos licitatórios ou contratuais, que pode levar à suspensão de obras ou à paralisação de repasses financeiros.

Causas Possíveis:

- 4. 99.

  Atrasos na emissão de licenças ambientais, autorizações de obras, alvarás ou anuências institucionais por órgãos competentes.

- 4. 100.

  Inadequações nos projetos quanto à legislação vigente (ambiental, urbanística, patrimonial ou sanitária).

- 4. 101.

  Demandas judiciais impetradas por terceiros ou participantes de licitações.

- 4. 102.

  Falta de regularização fundiária ou indefinições sobre titularidade dos terrenos das intervenções.

- 4. 103.

  Desconhecimento ou não atendimento de exigências legais específicas aplicáveis a projetos financiados com recursos internacionais.

Efeitos Negativos Potenciais:

- 4. 104.

  Atraso no início ou na continuidade das obras e aquisições.

- 4. 105.

  Interrupção de repasses de recursos pelo banco financiador até a devida regularização.

- 4. 106.

  Necessidade de readequação de projetos ou exclusão de ações inicialmente previstas.

- 4. 107.

  Aumento de custos com consultorias jurídicas e adequações técnicas.

- 4. 108.

  Redução da credibilidade institucional junto aos órgãos de controle e à população.

- 4. 109.

  Impacto direto sobre os cronogramas físico-financeiros e sobre os resultados esperados do programa.

Prevenção e Mitigação:
Diante dos possíveis impedimentos legais para a execução de obras e ações do PROSUS PI, serão adotadas estratégias preventivas e corretivas voltadas à garantia da conformidade jurídica e regulatória do programa, com foco na antecipação de exigências e articulação interinstitucional.

1. Levantamento prévio de requisitos legais e fundiários

- 4. 110.

  Realização de diagnóstico jurídico e técnico preliminar das áreas previstas para intervenções, verificando regularização fundiária, titularidade e zoneamento urbano.

- 4. 111.

  Mapeamento de exigências legais específicas para obtenção de alvarás, licenças ambientais e autorizações junto a órgãos competentes.

- 4. 112.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Diretoria Jurídica da SESAPI

2. Articulação com órgãos licenciadores e entidades reguladoras

- 4. 113.

  Atuação proativa com a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária e outros órgãos emissores de licenças e anuências.

- 4. 114.

  Estabelecimento de fluxos prioritários de análise e pactuação de cronogramas integrados com as obras do programa.

- 4. 115.

  Responsáveis: SESAPI, UGP e SEPLAN

3. Contratação de consultorias jurídicas e técnicas especializadas

- 4. 116.

  Apoio técnico-jurídico à elaboração de projetos e editais de licitação, assegurando aderência à legislação nacional e aos requisitos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

- 4. 117.

  Assessoria em processos complexos ou sujeitos à judicialização.

- 4. 118.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Procuradoria Geral do Estado (PGE-PI)

4. Acompanhamento contínuo de marcos regulatórios e exigências do financiamento internacional

- 4. 119.

  Adoção de checklists e matrizes de conformidade jurídica e ambiental alinhadas às diretrizes do BID e à legislação brasileira, com atualização periódica.

- 4. 120.

  Inclusão de cláusulas contratuais que exijam das empresas contratadas a responsabilidade pelo cumprimento de normas técnicas e legais.

- 4. 121.

  Responsáveis: UGP do PROSUS PI e Supervisão Técnica, Ambiental e Social (P.4.3)

5. Registro e documentação formal de todos os processos

- 4. 122.

  Organização e digitalização de todos os documentos legais, licenças, registros fundiários e certidões, garantindo rastreabilidade e suporte à fiscalização e auditoria.

- 4. 123.

  Responsáveis: UGP e Diretoria Administrativa da SESAPI

Estas ações têm por objetivo mitigar atrasos e sanções decorrentes de pendências legais, garantir o cumprimento da legislação aplicável em todas as fases do programa e assegurar a fluidez e regularidade na execução do PROSUS PI, fortalecendo a credibilidade institucional perante os órgãos de controle, os parceiros federais e o banco financiador.

4. 124. **Anexos**

Sem anexos.

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	Real	0.1685	873.600.000,00	147.201.600,00

5. 1. 1. Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	240	300

Juros aplicáveis:
CDI - Vida Média Ponderada (VMP) no momento de cada desembolso + Margem de Capital Ordinário (margem definida anualmente pelo Diretório do BID, fixada em 0,8% ao ano para 2025).
Periodicidade dos Pagamentos:
semestral
Comissão de Compromisso:
semestral
Comissão de Avaliação:
0,5% semestral do valor do saldo do desembolso
Taxa de Abertura:
0
Outros encargos:

0

Outras Informações:

V.1.11. Juros Aplicáveis:

CDI - Vida Média Ponderada (VMP) no momento de cada desembolso + Margem de Capital Ordinário (margem definida anualmente pelo Diretório do BID, fixada em 0,8% ao ano para 2025).

Tabela de VMP (data base 03/2025)

VMP	Base CDI*
3	-1.21
4	-1.10
5	-1.01
6	-0.91
7	-0.82

8	-0.74
9	-0.67
10	-0.61
11	-0.51
12	-0.42
13	-0.32
14	-0.22
15	-0.13

Portanto, considerando uma VMP média de 10 anos em março de 2025 e uma taxa CDI próxima de 13%, o custo anual inicial aproximado do financiamento em reais é: CDI(13%)?0,61%(spread VMP)+0,8%(capital ordinário)=13,19%ao ano.

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
CONSOLIDAÇÃO DO ACESSO E DOS SERVIÇOS NAS REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE - FORTALECIMENTO					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
39.443.040,00	5.667.480,00	98.602.140,00	14.163.240,00	118.323.660,00	16.996.980,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
98.602.140,00	14.163.240,00	39.426.660,00	5.656.560,00		

Nome do componente					
APRIMORAMENTO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E INOVAÇÃO					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
20.605.875,00	12.356.754,45	51.520.560,00	30.881.372,78	64.537.530,00	34.333.254,45
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
54.250.560,00	28.151.372,77	20.567.655,00	12.349.745,55		

Nome do componente					
FORTALECIMENTO DE MODELOS DE ATENÇÃO E CUIDADOS					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.694.780,00	0,00	14.239.680,00	0,00	17.089.800,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
14.239.680,00	0,00	5.700.240,00	0,00		

Nome do componente					
GESTÃO DO PROGRAMA					
Tipo de condição					
F1					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
3.603.600,00	0,00	9.009.000,00	0,00	10.810.800,00	0,00
4° ano		5° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
9.009.000,00	0,00	3.603.600,00	0,00		

5. 3. **Contragarantias**

não se aplica.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

O Estado do Piauí vem desenvolvendo, desde 2021, um processo consistente de planejamento e articulação interinstitucional com vistas à reestruturação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e à qualificação da oferta de serviços de saúde em todo o território estadual. As ações prévias necessárias à execução do Programa de Fortalecimento do SUS do Estado do Piauí (PROSUS PI) já foram iniciadas e se encontram em estágio avançado, criando uma base sólida para a implementação do projeto.

Um dos marcos fundamentais foi o desenvolvimento do Processo de Planejamento Regional Integrado (PRI), coordenado pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (SESAPI), com o apoio técnico do Ministério da Saúde e a participação ativa de diferentes atores institucionais, como o Conselho Estadual de Saúde, o Conselho de Secretários Municipais de Saúde (COSEMS), a Universidade Federal do Piauí (UFPI/NESP) e o próprio Ministério da Saúde.

O PRI permitiu a identificação e pactuação, no âmbito da Comissão Intergestores Bipartite (CIB), dos macroproblemas e das prioridades sanitárias das 4 Macrorregiões de Saúde e das 12 Regiões de Saúde do Estado. A partir desse diagnóstico territorial, foram mapeados os vazios assistenciais e definidas as áreas prioritárias para investimento, servindo de base técnica para a elaboração dos principais instrumentos de planejamento estadual: o Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 e o Plano Estadual de Saúde (PES) 2024–2027.

Essas ações preliminares permitiram alinhar as diretrizes estratégicas do Estado aos objetivos do PROSUS PI, garantindo coerência entre diagnóstico, planejamento e proposta de financiamento.

Além disso, o Estado já iniciou a mobilização de recursos complementares junto ao Governo Federal, tendo sido contemplado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) com a construção de importantes equipamentos de saúde, que contribuirão diretamente para a consolidação das Redes de Atenção e para a sustentabilidade dos investimentos previstos no PROSUS PI. Dentre esses equipamentos, destacam-se:

- 6. 2.

  3 Policlínicas;
- 6. 3.

  1 Centro Especializado em Reabilitação (CER IV);
- 6. 4.

  2 Maternidades de Baixo Risco;
- 6. 5.

  1 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS);
- 6. 6.

  3 Centros de Parto Normal.

Essas ações demonstram o compromisso do Estado com o fortalecimento da rede de saúde, e evidenciam que o PROSUS PI está alicerçado em etapas prévias concretas e articuladas com políticas públicas nacionais e estaduais, conferindo maior viabilidade e sustentabilidade à sua execução.

6. 7. Anexos

Sem anexos.